

TROISIEMES JOURNÉES SCIENTIFIQUES DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE L'UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI



THEME :
LA FSS FACE AUX DEFIS
SANITAIRES
CONTEMPORAINS

FSS Champ de Foire du 01 au 05 Octobre 2024



MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA MICROFINANCE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



BIENVENUE AUX

3^{ème} journées scientifiques

Des Sciences de la Santé de l'Université d'ABOMEY-CALAVI



LIVRE DES RESUMES

MOT DE BIENVENUE DU DOYEN



Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues,

La Faculté des Sciences de la Santé renoue avec sa tradition de vulgarisation des résultats scientifiques de sa communauté et a donc le plaisir d'organiser les 3èmes journées Scientifiques du 1er au 5 Octobre 2024.

Cette 3ème édition des journées scientifiques se déroule en 2 parties : Un précongrès et le congrès proprement dit. Le pré congrès consiste en des activités de consultations foraines gratuites, de dépistage et de sensibilisation à la Faculté des sciences de la santé d'une part et dans le village de Lokpodji –commune de So-Ava d'autre part. Dès le Jeudi 03 Octobre la conférence scientifique aura lieu à la FSS et permettra aux enseignants et chercheurs de la FSS et de la communauté universitaire nationale et internationale de vulgariser leur résultat de recherche. En assurant les consultations foraines dans différentes spécialités médicales dans le village de Lokpodji , commune de So Ava du 01 au 02 Octobre, la Faculté assure en partie l'une de ses obligations , celle de sa responsabilité sociale envers la communauté. Les conférences dédiées au grand public, de même que les dépistages des maladies non transmissibles telles que la drépanocytose, le diabète et l'hypertension confirme la volonté de la FSS d'une faculté promotrice de la santé : agir avant la survenue de la maladie.

Cette activité a bénéficié d'un accompagnement des anciens étudiants « Alumni de la Faculté » et au nom de toute la communauté facultaire je tiens à leur dire un grand merci. Merci également aux bonnes volontés et aux sponsors. C'est également l'occasion pour moi de remercier toute la communauté facultaire : les étudiants, le personnel administratif et les enseignants, les différentes autorités du ministère de la santé, le directeur départemental de la santé de l'Atlantique, le médecin coordonnateur de la zone sanitaire, ainsi que les autorités politico-administratives de la commune de So-Ava.

Que vive la FSS au service de la communauté ! Vive la FSS promotrice de la santé !

Que vive la Science

Je vous remercie

SOMMAIRE

Organisation de la journée	6
Programme scientifique	8
Résumés des conférences	12

Organisation de la Journée

Equipe décanale

Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou

(BENIN)

Doyen : Pr AVAKOUDJO Josué Dejinnin Georges

Vice doyen médecine : MCA VODOUHE Ulrich Bidossèssi

Vice doyen pharmacie : MCA GANFON Medessou Yoweil Habib

Vice doyen des écoles : Pr AZON KOUANOU Angèle

COMITE SCIENTIFIQUE

COMITE SCIENTIFIQUE	
PRESIDENT	Pr ZOMALHETO Xavier Cossi Vice : Pr GBESSI Dansou Gaspard
MEMBRES	Pr ADJIBABI Wassi Pr MEHINTO Delphin Kuassi Pr LALEYE Anatole O A Pr AMOUSSOU-GUENOU Marcelin Kuassi Pr FIOGBE Michel Armand Pr HANS-MOEVI Aristote Pr KPADONOU Toussaint Godonou Pr ODOULAMI-YEHOUESSI Lisette Pr ZOUMENOU Eugène Pr DENAKPO Justin Lewis Pr ADEGBIDI Hugues Daniel Gbadébo Pr AFFOLABI Dissou Pr ALAO Modjere Ola Maroufou Jules Pr ATADOKPEDE Agbomènou Félix Pr AWEDE Bonaventure Lucien Sévérin

	Pr FIOSSI KPADONOU Emille Pr TONATO BAGNAN Joslane Angéline A Pr ADJIEEN Kodjo Constant Pr OGOUYEMI HOUNTO Aurore Bertille Pr SEHONOU Jean Pr AGODOKPESSI Gildas Pr ALAMOU Soulé Pr ALLABI Aurel Constant Eustache Pr AYELO Ahounmènou Paul Pr GNONLONFOUN Dieu Donné Pr HOUNKPATIN Benjamin Ignace Bodounrin Pr TSHABU AGUEMON Christiane Pr YEKPE AHOUANSOU Hermione Patricia Frida Pr AGUEMON Badirou Din Pr ALAGNIDE Hountondji Etienne Pr AZON KOUANOU Angèle Pr AVAKOUDJO D. Josué Pr HINSON Vickey Antoine Pr HOUNKPE Pierre Claver Pr LALYA Francis Honorat Pr VIGAN Jacques Pr CODJO Houétondji Léopold Pr YEMOA Loconon Y Achille
--	---

COMITE D'ORGANISATION

COMITE D'ORGANISATION	
PRESIDENT	Pr LALYA Francis Honorat
VICE-PRESIDENT	MCA AGBODANDE Kouessi Anthelme
SECRETARIAT DU CONGRES	MCA AZONBAKIN Azandégbé Simon MCA ALIHONOU Thierry MCA BAGNAN TOSSA Léhila MCA WANVOEGBE Armand MCA BIGOT Cédric Egnonwa Parfait MCA GNANGNON Freddy Houehanou Rodrigue MCA HODONOU Dètonджи Fred Jean-Martin MCA IMOROU SOUAIBOU Yacoubou MCA KPOSSOU Aboudou Raimi MCA LAWANI Ismail MCA OGOUDJOBI Ogourindé Mathieu MCA SEIDOU Falilatou MCA WACHINOU Ablo Prudence MA ADJAGBA Mahouna Philippe Dotou MA ZOHOUN Comlan Gildas Alban MA AHOUNOU Ernest Stéphane MA AIGBE Nestor Dr MIZEHOUN Carmelle MA AGBOKPONTO Janvier Engelbert MA ASSANHOU Assogba Gabin MA HOUNDETOUNGAN David Gilles Dr HOUEZE Richard Ghislain Constantin Dr CHABI Yossounon Dr TOHON Gbèdolo Honesty Dr HOUNGBEDJI Germain Mme IDOSSOU Valérie Mme TOUDONOU Sabine M. DOSSOU Guy Modeste Mme DAH-ZOUNDEJI Nicarette Mme ESSEGNON Germaine

COMITE D'ORGANISATION

COMMISSION ACCUEUIL- HEBERGEMENT- TOURISME- RESTAURATION PRESIDENT VICE-PRESIDENTE	MCA ABOUBACAR Moufalilou Mme AYELESSO Diane Sous-commission Accueil MCA ADJADOHOUN Sonia B M Gwladys MCA CHIGBLO Sègla Pascal Eric MCA ZOHOUN GUIDIGBI Lutécia Myria A MA MIZEHOUN Gbèdécon Carmelle MA GOUKODADJA Oswald Dr VODOUHE Sèthcégnon Yéa Tchimon Dr OREKAN Folakèmi A. Jeanne Dr KOGUI DOURO Akim Mr ADOUGOUNDE Sylvestre Sous-commission Hébergement MCA AKODJÈNOU Joseph MCA SONOU Djidjoho Joel Armand MA BANKOLE POGNON Sylvie Arlette A MA BAGLO Dédè Priscillia Ttatia MA SOSSA Jean Dr HOUNSOU Nounagnon René Dr TOHODJEDE Yévèdo Mr ADJIGNON SOGNIGBE Maxime Sous-commission Restauration MCA KLIKPO Tchédié Etdéchié Elvyre MA ADJOBILEY Ménonli MA VIGNON Koffi Rodolphe Mme GANKPA Charmine Mr GOMINA Yasid Sous-commission Tourisme MCA MIKPONHOUE OLOU Rose Christelle MCA BOGNON Gilles Modeste Gilles MA TOKOUDAGBA Kossi Jean-Marie Denis
--	--

COMITE D'ORGANISATION

COMMISSION FINANCES	
PRESIDENT	MCA KLIKPO Elvyre
VICE-PRESIDENT	Mme GUEDOU-BEHANZIN Rose
	Pr MCA AVAKOUDJO François
	MCA LAWSON AFFOUDA Sonia
	MCA SISSINTO SAVI DE TOVE Yolande
	MCA ATTOLOU Sètonджи Roger Gilles
	MCA PADONOU Sètonджи Géraud Roméo
	MCA TOGNIFODE Medesse Véronique
	MCA YEVI Dodji Magloire Inès
	MCA BIGOT Cédric Egnonwa Parfait
	MCA GNANGNON Freddy Houehanou Rodrigue
	MCA KEREKOU HODE Annelie
	MCA HODONOU Dètonджи Fred Jean-Martin
	MCA SEIDOU Falilatou
	MCA ANAGONOU Lary Lucrèce
	MCA DEGBOE Kai Bérénice Esthelle
	MCA PADONOU Caroline Sourou Clémence
	MCA ABOUBACAR Moufalilou
	MCA ABOUKI Chakirou Olaidé Adoukê
	MCA ADJADOHOUN Sonia B M Gwladys
	MCA AKODJENOU Joseph
	MCA BOGNON Gilles Modeste Alain
	MCA CHIGBLO Sègla Pascal Eric
	MCA MIKPONHOUE OLOU Rose Christelle
	MCA PADONOU Abiodun Adébola Djossè
	MCA ZOHOUN GUIDIGBI Lutécia Myria A
	MCA BADOU Agnès Oladun Sylvie
	MA AZA-GNANDJI Guy -Gérard
	Dr AYI MEGNANGLO Codjo Austher
	Mme NOUDJENOUME Estelle
	Mr TOVIHO Ezechiel
	Mr ADJIGNON SOGNIGBE Maxime
	Mr GOMINA Yasid
	Mr HONFOGA Horace Pio

COMITE D'ORGANISATION

COMMISSION ACCUEUIL- HEBERGEMENT- TOURISME- RESTAURATION PRESIDENT VICE-PRESIDENTE	MCA ABOUBACAR Moufalilou Mme AYELESSO Diane Sous-commission Accueil MCA ADJADOHOUN Sonia B M Gwladys MCA CHIGBLO Sègla Pascal Eric MCA ZOHOUN GUIDIGBI Lutécia Myria A MA MIZEHOUN Gbèdécon Carmelle MA GOUKODADJA Oswald Dr VODOUHE Sèthcégnon Yéa Tchimon Dr OREKAN Folakèmi A. Jeanne Dr KOGUI DOURO Akim Mr ADOUGOUNDE Sylvestre Sous-commission Hébergement MCA AKODJÈNOU Joseph MCA SONOU Djidjoho Joel Armand MA BANKOLE POGNON Sylvie Arlette A MA BAGLO Dédè Priscillia Ttatiaana MA SOSSA Jean Dr HOUNSOU Nounagnon René Dr TOHODJEDE Yévèdo Mr ADJIGNON SOGNIGBE Maxime Sous-commission Restauration MCA KLIKPO Tchédié Etdéchié Elvyre MA ADJOBILEY Ménonli MA VIGNON Koffi Rodolphe Mme GANKPA Charmine Mr GOMINA Yasid Sous-commission Tourisme MCA MIKPONHOUE OLOU Rose Christelle MCA BOGNON Gilles Modeste Gilles MA TOKOUDAGBA Kossi Jean-Marie Denis
	MA HOUNKPONOU AMOUSSOU-GUENOU Eliane Kayivi Murielle Mr TOVIHO Ezechiel Mr HONFOGA Horace Pio
COMMISSION SANTE PRESIDENT VICE-PRESIDENT MEMBRES	ZOUMENOU Eugène AKODJENOU Joseph MCA SONOU Djidjoho Joel A. AHOUNOU Ernest Dr DAHOUE Richard M. ADOUGOUNDE Sylvestre



**AMBASSADE
DE FRANCE
AU BÉNIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**AGENCE BÉNINOISE
DE GESTION INTÉGRÉE
DES ESPACES FRONTALIERS**



**MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN**



**MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA MICROFINANCE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN**



**MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN**



Programme scientifique

TROISIEMES JOURNÉES SCIENTIFIQUES DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE L'UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

Sous-thème :

- Les maladies à potentiel épidémique ;
- La collaboration interdisciplinaire ;
- Le rôle des pharmaciens dans la promotion de la santé au Bénin ;
- La qualité de la nutrition : la FSS face aux défis de socio-sanitaires

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

MARDI 1er OCTOBRE 2024

HORAIRE	ACTIVITES		
8h-8h30	Accueil des participants	9h-16h	9h-16h
8h30-9H00	MOT DE LANCEMENT DU DOYEN [GRAND AMPHI MEDECINE]	JOURNEE DE CONSULTATIO NS FORAINES A LOKPODJI	CAMPAGNE DE DEPISTAGE- SENSIBILISA TION- DON DE SANG
9H-10H30	CONFERENCE GRAND PUBLIC 1 : PREVENTION DES HEPATITES VIRALES ET DU CANCER DU FOIE Pr Raïmi KPOSSOU [GRAND AMPHI MEDECINE] MODERATEURS: Pr SEHONOU, Pr ATADOKPEDE,		
10H30-12H	CONFERENCE GRAND PUBLIC 2 : LA MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION, la KINESITHERAPIE ET L'ERGOTHERAPIE : QUEL ENCRAGE DANS LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP ? Dr Alexandre FATON [FONDATION VALLET] MODERATEURS: MCA CHIGBLO P, Dr DANSOU Eugénie		
15H-16H30	CONFERENCE GRAND PUBLIC 3 : PREVENTION DES RISQUES CARDIO VASCULAIRES Dr Virgile YADOULETON [GRAND AMPHI MEDECINE] MODERATEURS: MCA SONOU A, Dr HOUNKPONOU Murielle		

MERCREDI 2 OCTOBRE 2024

9H-10H30	CONFERENCE GRAND PUBLIC 4 : LA CHAISE TUE Pr Eugène ZOUMENOU [GRAND AMPHI MEDECINE] MODERATEURS: Pr CODJO Léopold, Dr Alexandre Faton	JOURNEE DE CONSULTATIO NS FORAINES A LOKPODJI	CAMPAGNE DE DEPISTAGE- SENSIBILISA TION- DON DE SANG
10H30-12H	CONFERENCE GRAND PUBLIC 5 : HYGIENE MENSTRUELLE : PARLONS-EN : Pr Christiane T. AGUEMON [AMPHI ISBA] MODERATEURS: Pr DENAKPO Justin, MCA MOUFALILOU		
15H-16H30	CONFERENCE GRAND PUBLIC 6 : MA SANTE MENTALE, J'EN PRENDS SOIN ; Pr Lucrèce ANAGONOU [GRAND AMPHI MEDECINE] MODERATEURS: Pr Elvire KLIKPO, Dr Yacoubou Anatou		

JEUDI 3 OCTOBRE 2024

8h30 - 9h15	CEREMONIE D'OUVERTURE [GRAND AMPHI MEDECINE] Allocution doyen FSS (5min) Allocution Recteur (5min) Allocution MASM (5min) Allocution MS (5min) Allocution MESRS : ouverture (5-10min)		
9H30-10H	CONFERENCE INAUGURALE : LE ROLE DE LA FSS FACE AUX DEFIS SANITAIRES : PR ABDOU RAHMANN AGUEMON [GRAND AMPHI MEDECINE] Modérateurs : Pr ZANNOU DJIMON MARCEL, Pr OUENDO Marius , Pr HINSON Vickey		

10H-10H30	CONFERENCE 1 : RESPONSABILITE SOCIALE DE LA FSS : MR LE DOYEN DE LA FSS (GRAND AMPHI MEDECINE) Modérateurs : Pr ZANNOU DJIMON MARCEL, Pr OUENDO Marius , Pr HINSON Vickey
10H30-11H	Pause-café, visite des posters, visite des stands
11H-12H30	Modérateurs : Pr SEHONOU Jean, Pr AGBODANDE Anthelme, Dr DJOSSOU Julien TABLE RONDE 1 : AVANCEES, DEFIS ET PERSPECTIVES DANS LA LUTTE CONTRE LES MALADIES PRIORITAIRES AU BENIN (GRAND AMPHI MEDECINE) – Rôle du CNLS- TP Dr Simone KOUNOUHO HOUNNANKAN – Cas du PNLP Dr Codjo DANDONOUGBO – Cas du PNLH Dr Sossa GBEDO – Cas du PSLS Dr Moussa BACHABI – Cas PNT Pr Dissou AFFOLABI – Cas du PNSP Pr Anthelme K. AGBODANDE
SESSION 1 : MALADIES PRIORITAIRES, COVID19 ET AUTRES	
12H30-13h30	Modérateurs : Pr WANVOEGBE Armand, MCA WACHINOU Ablo, Dr DANSOU Eugénie (AMPHI ISBA) COMMUNICATIONS ORALES CO1-CO10 (5 mn par communication) CO1 : COMPRENDRE LA PREPARATION ET LA REPOSE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 AU BENIN ROCH HOUNGNIHIN CO2 : L'HESITATION VACCINALE EN CONTEXTE PANDEMIQUE DE COVID-9 : PERCEPTIONS ET MOTIVATIONS DES ACTEURS A COTONOU ROCH HOUNGNIHIN CO3 : LES FRONTIERES EN CONTEXTE PANDEMIQUE DE COVID-9 AU BENIN : CONSTRUCTION SOCIALE DES DISCOURS ET DES PRATIQUES ROCH HOUNGNIHIN CO4 : HEPATITES VIRALES B ET C CHEZ LES DIABETIQUES ADULTES A COTONOU EN 2023 : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES KPOSSOU A.R. CO5 : HEPATITES VIRALES B ET C CHEZ LES HEMODIALYSES CHRONIQUES A COTONOU ET ABOMEY-CALAVI EN 2023 : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE ET DIAGNOSTIQUE KPOSSOU A.R. CO6 : FORMULATION GALENIQUE DE L'EXTRAIT AQUEUX DES FEUILLES D'ACALYPHA WILKESIANA MÜLL. ARG, PLANTE UTILISEE EN MEDECINE TRADITIONNELLE AU BENIN DANS LE TRAITEMENT DES MYCOSES. URBAIN C. CO7 : IDENTIFICATION DE MEDICAMENTS COMBINES ARTEMETHER-LUMEFANTRINE A L'AIDE DE SPECTROSCOPIE INFRAROUGE MOYEN ET D'OUTILS CHIMIOMETRIQUES ARISTIDE A.S. CO8 : LES COMMIS DE PHARMACIE DANS LA LUTTE CONTRE LES HELMINTHIASES AU SUD-BENIN : ENTRE RECOMMANDATIONS OFFICIELLES ET PRATIQUES SOCIALES ATSOU AFANYIZOU CO9 : PHYTOCHIMIE ET ACTIVITE ANTI BACTERIENNE DES COMBINAISONS DE DEUX PLANTES UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DE LA FIEVRE TYPHOÏDE AHOUANSOU C. CO10 : CELLULITE FACIO-CERVICO-THORACIQUE ODONTOGENE CHEZ DES GESTANTES HOUNLELOU V.E.
13h30-14h30	Déjeuner –pause
SESSION 2 : MALADIES NON TRANSMISSIBLES	
14h35-16H	Modérateurs : Pr ATADOKPEDE Félix, MCA IMOROU Souaïbou , Dr VIGNON Rodolph TABLE RONDE 2 : ROLE DES ORGANISATIONS DE SANTE FACE AUX DEFIS SANITAIRES CONTEMPORAINS AU BENIN (AMPHI ISBA)

	- ACTIVITES DE LA MEDECINE HOSPITALIERE FACE AUX FLEAUX SANITAIRES AU BENIN (10NMN) PR MARCEL ZANNOU - ACTIVITES DE L'ORDRE DES MEDECINS FACE AUX FLEAUX SANITAIRES (10NMN) DR Abou ADEGBINDIN - L'APPUI DE LA FSS DANS LA GESTION DES FLEAUX SANITAIRES (10 MN) PR ULRICH VODOUHE
16H05-17h05	CONFERENCE 2 : MALADIES A POTENTIEL EPIDEMIQUE : DEFIS ET PERSPECTIVES AU BENIN DR TOKPANOU KOUDJO (25mn) [GRAND AMPHI MEDECINE] CONFERENCE 3: ÉPIDEMIOLOGIE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES : DR SALMANN AMIDOU (25mn) [GRAND AMPHI MEDECINE] DEBATS (10 mn)
17h15-18h30	COMMUNICATIONS ORALES CO11-CO19 (5mn/communication + échanges) [AMPHI ISBA] Modérateurs : Pr ADEGBIDI Hugues, Pr VIGAN Jacques, Dr YACOUBOU Anatou CO11 : ASTHME DE L'ENFANT : CONNAISSANCES ET PRATIQUE DES PEDIATRES EXERÇANT AU BENIN EN 2023 ALIHONOU F CO12 : SYNDROME CORONARIEN AIGU DU SUJET JEUNE AU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2023 : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, DIAGNOSTIQUES, THERAPEUTIQUES ET EVOLUTIFS ZANDA VOUGO M.M.M. CO13 : IDEES SUICIDAIRES CHEZ LES ETUDIANTS EN MEDECINE, PHARMACIE ET ODONTOSTOMATOLOGIE DES UNIVERSITES PUBLIQUES DU TOGO EN 2021 LEGBA AA CO14 : COMORBIDITE TROUBLE STRESS POST-TRAUMATIQUE ET CRISES FONCTIONNELLES DISSOCIATIVES : A PROPOS D'UN CAS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA EN 2024 LEGBA AA CO15 : FACTEURS ASSOCIES AUX RECIDIVES DE POUSSEES DOULOUREUSES DE LOMBARTHROSE DANS LE SERVICE DE RHUMATOLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU DJOSSOU J. CO16 : LES PATHOLOGIES MECANIKES NON TRAUMATIQUES DU RACHIS DORSAL DANS LE SERVICE DE RHUMATOLOGIE CNHU-HKM DE COTONOU LENOUMI G CO17 : FACTEURS ASSOCIES AUX RECIDIVES DE POUSSEES DOULOUREUSES DE GONARTHROSE DANS LE SERVICE DE RHUMATOLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU DJOSSOU J. CO18 : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES ET PRONOSTIQUES DES AVC DE LA FOSSE CRANIIENNE POSTERIEURE EN USINV AU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2023 TOVIWANOU R CO19 : HANDICAP PHYSIQUE ET INDEPENDANCE FONCTIONNELLE EN POST-ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE NEUROLOGIE DU CNHU-HKM EN 2022 : ETUDE DE PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIÉS HOUZE R
VENDREDI 4 OCTOBRE 2024	
	SESSION 3 : COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE
8h30-9h30	Modérateurs : Pr DOSSOU Francis, Pr AZON KOUANOU Angèle , MCA ANAGONOU Lucrèce CONFERENCE 4: CONCEPT ONE HEALTH: Pr Delphin MEHINTO (30mn) [GRAND AMPHI MEDECINE] CONFERENCE 5: MODELE DE COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE: Pr Armand WANVOEGBE (30mn) [GRAND AMPHI MEDECINE]
09h35-09h50	DEBATS
09h55-10h30	COMMUNICATIONS ORALES CO20-24 (5mn /communication + échanges) Modérateurs : Pr DOSSOU Francis, Pr KOUANOU Angèle , MCA ANAGONOU Lucrèce [AMPHI ISBA] CO20 : PREVALENCE ET FACTEURS DETERMINANTS DE TROUBLES ANXIO-DEPRESSIFS CHEZ LES LOMBALGIQUES CHRONIQUES AU CNHU-HKM DE COTONOU EZIN G

	CO21 : DEPRESSION DU POST-PARTUM CHEZ LES ACCOUCHEES DES CENTRES DE SANTE DE LA COMMUNE D'ABOMEY EN 2024 KLIKPO E CO22 : FREQUENCE ET FACTEURS ASSOCIES AUX DECES NEONATAUX A L'HOPITAL SAINT JEAN DE DIEU DE BOKO EN 2023 KPANIDJA MG CO23 : CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES PHARMACIENS D'OFFICINE SUR L'ÉPILEPSIE AU BÉNIN EN 2023 HOUEZE R CO24 : APPORT DE L'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE DANS LE DIAGNOSTIC DES TUMEURS CEREBRALES AU CNHU-HKM DE COTONOU : A PROPOS DE 58 CAS WHENU S.P.U.
10h30-11h	Pause-café, visite des posters, visite exposition pharmaceutique
	SESSION 4 : ROLE DES PHARMACIENS
11h-12h30	COMMUNICATIONS ORALES CO25-CO29 (5mn /communication + échanges) (GRAND AMPHI MEDECINE) Modérateurs : Pr Dissou AFFOLABI, MCA Junior AZONBAKIN CO25 : CONTRIBUTION DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE COTONOU À LA RECHERCHE SUR LES PLANTES MÉDICINALES ENTRE 2006 ET 2022 HABIB GANFON CO26 : CONTRIBUTION A L'ETUDE DES TISANES REPUTES AMAIGRISSANTES, COMMERCIALISEES A COTONOU ET ABOMEY-CALAVI HABIB GANFON CO27 : ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ CYTOTOXIQUE DE TROIS PLANTES DE LA PHARMACOPÉE BÉNINOISE AXEL AHOUANSSOU CO28 : IDENTIFICATION DES FALSIFICATIONS AUX ANTALGIQUES ET ANTI-INFLAMMATOIRES USUELS DANS DES PHYTOMEDICAMENTS REPUTES ANTIDOULEURS ET COMMERCIALISÉS A COTONOU ET ABOMEY-CALAVI HABIB GANFON CO29 : CARACTERISATION PHYSICOCHIMIQUE DU MIEL APISAVANA EN VUE DE SON UTILISATION COMME MATIERE PREMIERE PHARMACEUTIQUE HERMINE ZIME-DIAWARA
12h45-14h	Modérateurs : Pr GNONLONFOUN Dieudonné, MCA Elvire KLIKPO, Mr Eustache YOVO TABLE RONDE 3 : ROLE DES PHARMACIENS DANS LA PROMOTION DE LA SANTE AU BENIN (AMPHI ISBA) - LES ACTIVITES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DANS LA PROMOTION DE LA SANTE (ONPB) - LA PHARMACIE HOSPITALIERE : QUELS ENJEUX POUR LE BENIN : DR ALINE AGUEGUE - LA RECHERCHE PHARMACEUTIQUE AU BENIN : QUEL PROGRES ? PR Achille YEMOA - ADEQUATION DE LA FORMATION ET BESOINS EN PHARMACIENS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE: MCA HABIB GANFON
	DEBATS
14h-15h	Déjeuner- pause
	SESSION 5 : NUTRITION ET METABOLISME
15H05-16H30	Modérateurs : Pr Anatole LALEYE, Pr Jean SOSSA, Mr Gilchrit LENOUMI TABLE RONDE 4 : LES ECOLES DE LA FSS FACE AUX DEFIS DE SANTE PUBLIQUE (GRAND AMPHI MEDECINE) LA FORMATION EN NUTRITION : UN ENJEU DU DEVELOPPEMENT DE LA SANTE: MCA COLETTE AZANDJEME LA KINESITHERAPIE A LA CROISEE DES CHEMINS ; DR GERMAIN HOUNGBEDJI LES TRAVAILLEURS SOCIAUX FACE AUX DEFIS SANITAIRES : Dr Valérie IDOSSOU DIFFICULTES DE LA FORMATION EN NUTRITION A LA FSS DE COTONOU : PR Angèle A. KOUANOU ROLE DES ASSISTANTS SOCIAUX DU MASM DANS LA PROMOTION DE LA SANTE ET LA PRISE EN CHARGE SOCIO-SANITAIRE DES INDIGENTS (MC Agnès BADOU)
	DEBATS

16h35-17H	CONFERENCE 6: NUTRITION ET INFERTILITE: UN LIEN A NE PAS NEGLIGER: MCA Junior AZONBAKIN (GRAND AMPHI MEDECINE)
17h05-18h30	COMMUNICATIONS ORALES CO30-34 (5mn /communication + échanges) (GRAND AMPHI MEDECINE) CO30 : EFFICACITE DU PROJET DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES ENFANTS DE 6 A 59 MOIS DANS LA COMMUNE DE LALO AU BENIN SOSSA PAMELA CO31 : FRÉQUENCE ET FACTEURS ASSOCIÉS A LA MALNUTRITION CHEZ LES ENFANTS DE 6 A 59 MOIS DANS LES CENTRES DE SANTÉ DE PARAKOU EN 2024 KPANIDJA MG CO32 : PREVALENCE DE L'HYPERGLYCEMIE CHEZ LES TRAVAILLEURS DE NUIT D'UN CENTRE HOSPITALIER DE ZONE AU BENIN MIKPONHOUE OLOU ROSE CO33 : HYPERTENSION ARTERIELLE NON CONTROLEE MASQUEE A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE DU CNHU –HKM EN 2023 : FREQUENCE ET FACTEURS ASSOCIES. HOUNKPONOU M CO34 : PREVALENCE ET FACTEURS DE RISQUE DU DEFICIT EN VITAMINE D CHEZ LES NOURRISSONS DANS DEUX COMMUNES AU SUD DU BENIN EN 2023 TOHODJEDE Y
SAMEDI 5 OCTOBRE	
08H30-08H50	SYMPOSIUM LABORATOIRE phénix partners
9H-10H	Modérateurs :Pr Bonaventure AWEDE, Pr GBESSI Gaspard, Pr Léopold CODJO TABLE RONDE 4 : PROCESSUS DE REEVALUATION DES ENSEIGNANTS ADMIS AU GRADE CAMES: RATIONNEL ET DISPOSITIONS PRATIQUES (AMPHI ISBA) PROCESSUS DE REEVALUATION DES ENSEIGNANTS : REGARD DES ETUDIANTS (SYLVESTRE ADOUGOUNDE) PROCESSUS DE REEVALUATION DES ENSEIGNANTS : APPRECIATION DE L'ENSEIGNANT (MCA IMOROU SOUAÏBOU) PROCESSUS DE REEVALUATION DES ENSEIGNANTS : DISPOSITIONS ET MISE EN ŒUVRE (PR ULRICH VODOUHE, VD MEDECINE)
10h-10h30	Pause-café, visite des posters, visite des stands
10H45-12H00	COMMUNICATIONS LIBRES CO35-42 (5mn /communication + échanges) (GRAND AMPHI MEDECINE) Modérateurs : Pr YEKPE AHOUANSOU Patricia, MCA Elvire KLIKPO, Dr Murielle HOUNKPONOU CO35 : UN DANGEREUX CORPS ETRANGER TRACHEAL MIGRANT LAWSON AFOUDA S. CO36 : CAS D'UN CORPS ETRANGER NASAL PERFORANT LAWSON AFOUDA S. CO37 : ORTHODONTIE : A QUOI ÇA SERT ? DOHOU G. A. M. CO38 : PRODUCTION DES RESSOURCES HUMAINES EN MEDECINE NUCLEAIRE AU BÉNIN : ETAT DES LIEUX EN 2024 HOUNDETOUNGAN GD CO39 : ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES ETUDIANTS POUR AMELIORER L'ENSEIGNEMENT DE BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE EN 3EME ANNEES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE A LA FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE DE COTONOU OREKAN FAJ CO40 : PREVALENCE DU BURNOUT CHEZ LES SOIGNANTS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU MIKPONHOUE OLOU ROSE CO41 : PROFIL PSYCHOPATHOLOGIQUE DES SUJETS REÇUS EN EXPERTISE PSYCHIATRIQUE PENALE AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIQUE DE COTONOU DE 2018 A 2023 KLIKPO E CO42 : ESTIMATION DE L'AGE OSSEUX EN IRM DU FOOTBALLEUR DE MOINS DE 17 ANS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU AYI MEGNANGLO C.A.
10H45-12H00	COMMUNICATIONS LIBRES CO43-50 (5mn /communication + échanges) (AMPHI ISBA)

	Modérateurs : Pr TSABU-AGUEMON Christiane, Pr Honorat LALYA, Dr Marius ADJAGBA CO43 : SYNDROME CATATONIQUE CHEZ LES ADOLESCENTS : À PROPOS D'UN CAS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA EN 2024 DANIELLE MBWANG N.A CO44 : LA PRISE EN CHARGE DE L'INFRACLUSION ANTERIEURE EN ORTHOPEDIE DENTO FACIALE A PROPOS DE DEUX CAS COLLIGES AU CENTRE DE CONSULTATION ET DE TRAITEMENT DENTAIRE DE RABAT DAHOUÉ T. R. CO45 : ETHNOGRAPHIE DES SOLUTIONS ENDOGENES DANS L'AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES DE PF AUX JEUNES AU BENIN AGNES BADOU CO46 : LESIONS OCULAIRES LIEES A LA DEPIGMENTATION COSMETIQUE VOLONTAIRE AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA EN 2023 TONOUDO G CO47 : SATISFACTION GLOBALE DES PARENTS SUR LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES HOSPITALISES DANS L'UNITE DE NEONATOLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2024 BAGNAN TOSSA L CO48 : VECU DES MERES D'ENFANTS PORTEURS DE CARDIOPATHIES CONGENITALES SUIVIS AU CNHU-HKM DE COTONOU BAGNAN TOSSA L CO49 : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, CLINIQUES ET EVOLUTIFS DE L'ANEMIE NEONATALE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L'OUEME PLATEAU PADONOU BOKO C CO50 : TUMEURS CEREBRALES DE L'ADULTE AU CNHU-HKM : PROFIL HISTOLOGIQUE ET DEFIS DE LA PRISE EN CHARGE ALIHONOU T
12H00-12H30	CEREMONIE DE CLOTURE



Résumé des communications

La Faculté des Sciences de la Santé (FSS) est l'un des plus hauts lieux de la formation professionnelle du personnel de santé. Elle offre à ses apprenants les études médicales qui durent 7 ans après le baccalauréat puis différentes filières de formations qui font de ceux-ci, une fois sortie, des spécialistes confrontés aux difficultés des soins de santé publique.

Mais pour quels défis sanitaires ?

Il sont nombreux dans toute l'Afrique en général et au Bénin en particulier, nous distinguons :

- des affections endémiques tels que le VIH, le paludisme et la tuberculose ;
- des maladies chroniques comme le diabète, l'HTA ou le cancer ;
- des
- maladies émergentes comme le covid 19, l'Ébola, la fièvre Lassa, la variole de singe ;
- etc.

Et quelle est la responsabilité de la FSS face à ces différents défis ?

La FSS a une obligation de résultats en qualité et dans le suivi de ses médecins. Malheureusement, elle n'a pas un réel pouvoir de décision pour l'éradication des affections programmées. Bien que sous l'autorité administrative du Ministère de l'Enseignement Supérieur, elle se doit pour les quelques objectifs fixés de répondre aux besoins de la politique sanitaire nationale du Ministère de la Santé, de s'associer à la médecine traditionnelle aujourd'hui reconnue par l'OMS et à des partenaires techniques et financiers.

Le chemin est long et le problème de suivi est souvent rogné par la méfiance de la gouvernance.

La responsabilité sociale en santé consiste à répondre au mieux aux besoins et défis de santé des citoyens et de la société. Elle suppose la triade suivante : une identification de ces besoins et défis, une adaptation des missions des organisations et institutions pour y parvenir et un suivi assurant que les mesures prises produisent le meilleur impact sur la santé. (RIFRESS)

L'OMS a défini en 1995 la responsabilité sociale des facultés de médecine comme étant : « l'obligation d'orienter la formation qu'elles donnent, les recherches qu'elles poursuivent et les services qu'elles dispensent, vers les principaux problèmes de santé de la communauté, région ou nation qu'elles ont comme mandat de servir. »

La faculté des sciences de la santé s'est engagée dans la dynamique de la responsabilité sociale depuis sa création. Pour preuve le développement des différents CHU du Benin et la promotion du modèle de la santé communautaire qui a accouché l'initiative de BAMAKO.

Face aux défis actuels et futurs, la FSS doit anticiper et opérer les mutations structurelles nécessaires. Les sujets d'intérêt sont nombreux : L'intelligence artificielle, la digitalisation, les maladies émergentes et réémergences, l'exode des médecins béninois, la perte de vocation, les déserts médicaux du Benin, la vétusté des infrastructures académiques, l'inadéquation entre l'effectif massif des étudiants et la réduction inexorable de l'effectif des enseignants, la démarche qualité dans la formation médicale. La FSS et ses acteurs qui s'appropriant la vision de la « santé dans toutes les politiques » constituera une boussole pour les politiques promotrices de bien être des communautés béninoises et d'Afrique.

MALADIES A POTENTIEL EPIDEMIQUE : DEFIS ET PERSPECTIVES AU BENIN

Conf 2

Auteurs: T. Koudjo 1 , A. Goudoté 2 , R. Aho Glèlè 2 , B. Aniwanou 2 , F. Dossou 1 , B. Guezo-Mevo 2 .

1- Direction Générale de la Médecine Hospitalière et des Explorations Diagnostiques

2- Agence Nationale des Soins de Santé Primaires.

Introduction Depuis quelques années, plusieurs flambées épidémiques et autres Urgences de Santé Publique surviennent au Bénin : Fièvre Hémorragique Virale (Lassa), Choléra, COVID-19, Variole du Singe (MPOX), méningite, drames incendiaires, etc...sans oublier les menaces venant des pays voisins: FHV (Lassa) au Nigeria, conflits armés (Niger et Burkina Faso). Pour faire face à tous ces événements, les autorités compétentes, ont procédé au renforcement progressif de la capacité du pays à prévenir, à détecter précocement et à organiser la riposte dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement sanitaire International (RSI).

1- Organisation du système de la surveillance épidémiologique. : Le système de surveillance épidémiologique est organisé en trois niveaux (national, départemental et périphérique). Le niveau national à travers l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaire (ANSSSP) a pour attribution l'élaboration des politiques et stratégies, la coordination, la supervision, la formation pour la surveillance épidémiologique et la riposte. Quant au niveau départemental, il est chargé de la planification, de la supervision, de la formation sur la surveillance épidémiologique. Le niveau périphérique en ce qui le concerne, a pour attribution la supervision, la formation et la mise en œuvre de la surveillance et de la riposte.

2- Les défis : Des efforts consentis ont permis de maîtriser ces crises, mais nombreux sont les défis qui subsistent aux diverses actions qui sont menées. Il s'agit notamment entre autres de la mise en place d'une ligne budgétaire spécifique allouée aux activités du RSI, la prise d'acte administratif mettant en place le Point focal national RSI, le renforcement des capacités des chargés de surveillance en gestion des données avec les nouveaux outils de gestion électronique, l'Elaboration d'un plan de surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens selon l'approche « une seule santé », la réalisation régulière d'exercices de simulation pour tester la capacité du système de surveillance et de riposte aux zoonoses, la réalisation de la cartographie des maladies d'origine alimentaire et de POS de gestion des Urgences en matière de Sécurité Sanitaire des Aliments.

3- Les perspectives : En ce qui concerne les perspectives, il est à retenir la mise en oeuvre effective du Plan d'Action Nationale de Sécurité Sanitaire (PANSS) 2024 – 2028, la dynamisation de l'approche une seule santé ; la construction du Centre des Opérations des Urgences de Santé Publique (COUSP), la mise en place de l'Equipe Médicale d'Urgence (EMU) selon les normes de l'OMS, l'élaboration des guides pour les productions animales et la transformation des denrées alimentaires d'origine animale et l'amélioration du cadre juridique pour la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (RSI) 2005 en mettant à jour les textes législatifs et réglementaires nécessaires.

Conclusion : La ressurgence des maladies émergentes et reémergentes constitue une menace permanente pour la santé publique nationale comme internationale. La gestion de la pandémie Covid 19 a permis aux pays africains y compris le Bénin, d'améliorer leur système de surveillance, de riposte et de prise en charges des incidents de santé de portée internationale.

Mots clés: maladies à potentielle épidémique, surveillance sanitaire, riposte, Bénin.

Conf
4

CONCEPT ONE HEALTH

Pr Delphin Mehinto

Conf
3

EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Dr Salmann Amidou

Conf
5

MODELE DE COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE

Pr Armand Wanvoegbe

NUTRITION ET INFERTILITE DU COUPLE : MISE AU POINT EN 2024 ET DONNEES BENINOISES

Conf 6

Simon AZONBAKIN¹, Youriane ATEKA², Carmelle MIZEHOUN² et Anatole LALEYE¹

1- Service d'Histologie-Biologie de la Reproduction, Cytogénétique et Génétique Médicale . Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou , Bénin

2- Unité de Nutrition-Diététique , Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou , Bénin

Auteur correspondant : Dr AZONBAKIN Simon , MCA en Histologie Embryologie Cytogénétique , 01 BP 188 , FSS-UAC, Tel : 97 13 00 61 , E-mail : azandeq@yahoo.fr

L'infertilité représente un problème de santé affectant un nombre croissant de couples en âge de procréer. Parmi ses nombreuses étiologies, les maladies non transmissibles (MNT) comme l'obésité sont significatives. L'alimentation et les schémas nutritionnels sont sans aucun doute importants pour la fertilité masculine et féminine. Dans de nombreuses espèces, l'adaptation du système de reproduction aux saisons ou aux conditions climatiques a pour objectif d'optimiser les chances de survie de la descendance. Le système reproductif des femelles est plus sensible aux conditions nutritionnelles que celui des mâles car la grossesse et l'allaitement représentent une grande dépense énergétique. Nous nous sommes proposé de faire le point sur les facteurs nutritionnels associés à l'infertilité et de rapporter notre étude réalisée au Bénin en 2023 sur les facteurs nutritionnels associés dans 3 hôpitaux de Cotonou.

Mots clés : Infertilité, nutrition, alimentation et mode de vie.

Depuis l'année 2020, à l'instar de tous les pays du monde, le Bénin a été confronté à la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID-19. Dans le cadre de la réponse, plusieurs mesures ont été prises. Mais ces initiatives ont fait l'objet d'une faible appropriation sociale, en raison des enjeux de tous ordres, dont elles sont porteuses. C'est dans ce cadre que la présente recherche a été menée afin de comprendre la préparation et la réponse apportée à l'épidémie de la COVID-19 au Bénin, en insistant particulièrement sur la contribution des sciences sociales.

Il s'agit d'une enquête qualitative organisée auprès d'acteurs sociaux de différents profils. La recherche a intégré la réalisation d'une ethnographie associant des entretiens individuels et des observations in situ.

Comme la plupart des pays africains, le Bénin a répliqué les modèles adoptés dans les pays occidentaux ou impulsé de l'extérieur avec peu d'efforts de contextualisation : confinement, couvre-feu, contrôle des frontières, fermeture des établissements scolaires, suspension des compétitions sportives et autres grands rassemblements, etc. Il s'agit d'interventions classiques et standardisées mises en œuvre dans des contextes pourtant différents, générant leur faible appropriation sociale. Les différentes expériences rapportées révèlent que la COVID-19 a été une épidémie iconoclaste ayant imposé des interventions drastiques, socialement inacceptables, et ayant induit des modèles de causalité endogènes. Cette situation impose la nécessité d'une révision de la manière d'envisager la maladie et la santé. Dans cette perspective, les sciences sociales pourraient aider à comprendre et agir à plusieurs niveaux, sur les représentations de la maladie et la stigmatisation sociale, les effets sociaux des messages de santé publique, etc. Les connaissances empiriques acquises dans les pays permettent de se préparer mieux et plus vite en améliorant les stratégies et les procédures.

Mots clés : gouvernance, épidémie, sciences sociales, modèles voyageurs, Bénin

L'HESITATION VACCINALE EN CONTEXTE PANDEMIQUE DE COVID-9 : PERCEPTIONS ET MOTIVATIONS DES ACTEURS A COTONOU

Roch houngnihin

Anthropologue,

Laboratoire d'Anthropologie Médicale Appliquée, Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

Email : roch_houngnihin2001@yahoo.fr, Tél. +229 95061335

En l'absence de traitement spécifique face à la COVID-19, la stratégie mondiale a porté sur l'adoption de mesures de gestes barrières, de restriction des mobilités et de dépistage de masse. Dans ce contexte, l'urgence de développer un vaccin était devenu l'alternative la plus efficace pour contrôler la pandémie. Le Bénin a bénéficié de plusieurs livraisons de vaccins. Ainsi, dès le 29 mars 2021, le pays a pu démarrer la campagne de vaccination. A la date du 20 juin 2022, seulement 35,08 % de la population était complètement vaccinées (contre 60% prévus). La faible adhésion de la population était révélatrice d'un contexte d'hésitation vaccinale. C'est dans ce contexte que la présente étude a été réalisée aux fins de comprendre la perception et les motivations des acteurs.

L'approche méthodologique a consisté en la mise en place d'un système de veille et d'analyse des informations (médias, réseaux sociaux) et la réalisation d'enquêtes qualitatives.

Le contexte d'« épidémie de la peur » a été une raison majeure d'adhésion à la vaccination pour les populations. Les motifs d'hésitation vaccinale, quant à eux, ont porté sur le fait que pour des acteurs spécifiques (ayant accès à l'information scientifique), « le vaccin n'est pas la solution ». Pour la population générale, la thèse complotiste a été récurrente. A cela, se sont ajoutés les conflits larvés par scientifiques interposés, l'existence de sites de vaccination dispersés et en nombre réduit (au départ) et les coûts indirects associés. D'autres motifs d'hésitation vaccinale étaient en lien avec les lacunes informationnelles marquées par l'absence de sources d'informations crédibles sur la COVID-19, les vaccins disponibles, les effets secondaires, etc., dans un contexte où les réseaux sociaux paraissaient plus convaincants que le Gouvernement. Enfin, les facteurs intrinsèques aux vaccins (la rapidité de production des vaccins et leur grande diversité) méritent d'être soulignés.

Au total, l'existence d'un vaccin efficace et prouvé, n'est pas synonyme d'une forte adhésion.

Mots clés : vaccin, COVID-19, hésitation vaccinale, infox, anthropologie, Cotonou

LES FRONTIERES EN CONTEXTE PANDEMIQUE DE COVID-9 AU BENIN : CONSTRUCTION SOCIALE DES DISCOURS ET DES PRATIQUES

Roch houngnihin

Anthropologue,

Laboratoire d'Anthropologie Médicale Appliquée, Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

Email : roch_houngnihin2001@yahoo.fr, Tél. +229 95061335

Dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19, plusieurs mesures ont été prises dont la fermeture des frontières. Mais, très tôt, on a assisté à l'émergence de pratiques non conformes aux recommandations sanitaires, en termes de circulation des individus et des marchandises, complexifiant leur contrôle au niveau des espaces frontaliers et renforçant les risques de contamination. C'est dans ce contexte que la présente recherche a été menée aux fins de comprendre la « vie sociale » des frontières en contexte pandémique de COVID-19.

L'approche méthodologique a porté sur des entretiens semi-directifs et des observations réalisées auprès d'acteurs de différents profils : acteurs institutionnels, forces de l'ordre, soignants et populations. La substance clé de la gestion de la crise de la COVID-19 était le contrôle des mouvements internationaux. La réduction des mobilités a été l'une des premières réponses déployées par les Etats contre la propagation de la COVID-19 en Afrique. Au Bénin, la fermeture des frontières (par les pays voisins) a manqué, à l'évidence, d'effectivité, en raison de nombreuses pratiques émergentes non conformes aux recommandations sanitaires. Dans cette perspective, la pandémie de COVID-19 a constitué une opportunité pour comprendre le rôle ambivalent des frontières nationales et les logiques des différents acteurs sociaux impliqués, tant du côté des institutions publiques que des populations. La nature des facteurs explicatifs est hétérogène : organisation du travail au niveau des espaces frontaliers, perceptions et pratiques des populations et des acteurs institutionnels, etc. De façon générale, les modalités d'appropriation des mesures sanitaires sont divergentes. Elles sont révélatrices d'un climat à la fois d'anxiété, de défiance et de résignation. La pandémie a induit une reconfiguration des espaces frontaliers, faisant émerger une forme de stigmatisation sociale marquée par un contrôle sélectif des usagers. La grande porosité des frontières (terrestres surtout) et les logiques en jeu fondent la faible efficacité de la mesure de fermeture des frontières comme moyen de prévention de la COVID-19 au Bénin.

Mots clés : frontière - vie sociale - mobilité - COVID-19 – prévention – Bénin

HEPATITES VIRALES B ET C CHEZ LES DIABETIQUES ADULTES A COTONOU EN 2023 : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES

Kpossou AR^{1,2}, Sokpon CNM^{1,2}, Alade EOH², Vignon RK^{1,2}, Gbedo SE³, Kerekou Hode A¹, Séhonou J^{1,2}

¹Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

²Clinique Universitaire d'Hépatogastroentérologie du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (CNHU-HKM)

³Programme National de Lutte contre l'hépatite, Cotonou, Bénin

Correspondance : Dr Aboudou Raïmi KPOSSOU ; e-mail : kpossou.raïmi@yahoo.fr

Introduction : Le diabète et les maladies hépatiques chroniques telles que les hépatites B et C constituent des problèmes de santé publique mondiaux. L'association de l'infection par les virus d'hépatites (VHB) et (VHC) et le diabète augmente le risque de la survenue de la fibrose hépatique et de développement du carcinome hépatocellulaire. L'objectif de ce travail était d'étudier les hépatites virales B et C chez les diabétiques adultes dans des centres de santé de référence à Cotonou en 2023.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive et analytique à recueil prospectif qui s'est déroulée du 2 juillet 2023 au 31 octobre 2023 au CNHU-HKM, précisément à la Clinique Universitaire d'Endocrinologie Métabolisme Nutrition, et à la Banque d'insuline d'Akpakpa. Un test rapide a été utilisé pour le diagnostic d'hépatite B ou C.

Résultats : Au terme de cette étude, 281 patients ont été inclus. L'âge moyen des patients était de 60,4±11,2 ans avec des extrêmes de 22 à 88 ans. Les patients ayant un âge compris entre 61 à 70 ans étaient les plus représentés (37,7%). Les sujets de sexe féminin étaient majoritaires (61,6%) avec une sex-ratio de 0,6. Sur les 281 patients enquêtés, l'Ag HBS était positif chez 13 patients soit une prévalence de 4,6%. La PCR de de l'ADN du VHB était détectable chez 6 patients sur les 13 (soit 46,2% ou 2,1% de la population étudiée). L'anticorps anti-VHC était positif chez 5 patients soit une prévalence de 1,7%. La PCR de l'ARN du VHC était détectable chez 2 patients (soit 40,0% ou 0,7% de la population étudiée). Les facteurs associés retrouvés pour le VHB étaient l'âge ($p=0,010$), l'insulinothérapie ($p = 0,003$) et la cytolysé hépatique ($p = 0,003$) en analyse bivariée. En analyse multivariée, les antécédents chirurgicaux et l'insulinothérapie étaient statistiquement associés au VHB chez les diabétiques. Quant aux facteurs associés au VHC, il s'agissait en analyse bivariée de l'insulinothérapie ($p = 0,030$) et le score APRI ($p = 0,003$). En analyse multivariée, les antécédents chirurgicaux ($p=0,045$) et l'insulinothérapie ($p=0,030$) étaient statistiquement associés à la présence d'anticorps anti-VHC chez les diabétiques.

Conclusion : Les hépatites virales B et C sont fréquentes chez les diabétiques adultes. Les facteurs associés identifiés étaient l'âge, les antécédents chirurgicaux, insulinothérapie. Le dépistage systématique serait donc utile chez les diabétiques, afin de réduire la morbi-mortalité liée aux hépatites virales B et C.

Mots clés : Diabète de type 2, hépatite B et C, prévalence, facteurs associés

HEPATITES VIRALES B ET C CHEZ LES DIABETIQUES ADULTES A COTONOU EN 2023 : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES

Kpossou AR^{1,2}, Sokpon CNM^{1,2}, Alade EOH², Vignon RK^{1,2}, Gbedo SE³, Kerekou Hode A¹, Séhonou J^{1,2}

¹Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

²Clinique Universitaire d'Hépatogastroentérologie du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (CNHU-HKM)

³Programme National de Lutte contre l'hépatite, Cotonou, Bénin

Correspondance : Dr Aboudou Raïmi KPOSSOU ; e-mail : kpossou.raïmi@yahoo.fr

Les hémodialysées constituent une population à risque des hépatites B et C en raison de l'exposition à la transmission parentérale. L'objectif de ce travail était d'étudier les caractéristiques des hépatites virales B et C chez les hémodialysés chroniques à Cotonou et Abomey-Calavi. Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive et analytique qui s'est déroulée sur une période de trois mois allant de Septembre à Décembre 2023 chez les hémodialysés chroniques dans trois différents centres d'hémodialyse au Sud du Bénin. Etaient inclus les sujets âgés d'au moins 18 ans, traités par hémodialyse de façon itérative depuis au moins 3 mois et ayant donné leur consentement. Un recrutement exhaustif de tous les patients répondant aux critères d'inclusion a été réalisé. Un test rapide a été utilisé pour le diagnostic d'hépatite B ou C et une PCR a été réalisée pour la détermination de la charge virale. Résultats : Au total, 205 patients ont été inclus dans l'étude. L'âge moyen des hémodialysés chroniques était de 52,1± 12,2 ans avec des extrêmes allant de 23 à 85 ans. On notait une prédominance masculine (65,9%) avec une sex-ratio de 1,9. Les patients avaient majoritairement une néphropathie de types vasculaire (95,1%) et diabétique (15,5%). Les prévalences de l'Ag HBs et des anticorps anti-VHC étaient respectivement de 7,3%(15/205) et 10,2% (21/205). L'ADN du VHB était détectable chez les 15 patients ayant l'Ag HBs et l'ARN du VHC chez 14 patients sur les 21 ayant l'anticorps anti-VHC. En analyse multivariée, le seul facteur associé à l'AgHBs était l'hémorragie digestive (p=0,046), et celui associé à l'Ac anti-VHC était le nombre de centre d'hémodialysés fréquentés ≥ 3 (p=0,049). Conclusion : De ce travail, il ressort que les fréquences des hépatites virales B et C restent élevées chez les hémodialysés chroniques, surtout ceux ayant un antécédent d'hémorragie digestive ou ayant fréquenté au moins 3 centres d'hémodialyse.

Mots clés : VHB, VHC, hémodialysés chroniques, Cotonou, Abomey-Calavi

FORMULATION GALENIQUE DE L'EXTRAIT AQUEUX DES FEUILLES D'ACALYPHA WILKESIANA MÜLL. ARG, PLANTE UTILISEE EN MEDECINE TRADITIONNELLE AU BENIN DANS LE TRAITEMENT DES MYCOSES

Urbain C. KASSEHIN^{1,4*}, Gabin A. ASSANHOUE², Gracia M. TOKPANOU¹, Brice M. OHIN⁵, Alban HOUNGBEME¹, Habib Y. GANFON³, Virgile AHYI⁴, Fernand A. GBAGUIDI¹.

¹ CRDM-PharmaLab / Unité de Recherche en Chimie Organique et Pharmaceutique, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou -BENIN

² Centre de Recherche et de Développement du Médicament PharmaLab (CRDM-PharmaLab) /Unité de recherche en Pharmacie Galénique Industrielle, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou –BENIN

³ CRDM-PharmaLab / Unité de Recherche en Pharmacognosie et Phytothérapie, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou -BENIN

⁴ Inter-Regional University of Industrial Engineering Biotechnologies and Applied Sciences, Unité de formation en Ingénierie des Procédés de Production, Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie, 07BP231 Cotonou-BENIN.

⁵ Laboratoire de Microbiologie et des Technologies Alimentaires et de Phytopathologie (LAMITAP), Institut des Sciences Biomédicales

Appliquées (ISBA), Campus du Champ de foire, Cotonou, Bénin.

Les plantes de par leur importance constituent une alternative de premier choix dans le traitement des pathologies chez l'homme. *Acalypha wilkesiana* est une plante de la médecine traditionnelle béninoise fréquemment utilisée dans le traitement des mycoses. L'objectif à long terme de cette étude est de réaliser une formulation galénique de l'extrait aqueux des feuilles d'*A.wilkesiana* Müll. Arg (Euphorbiaceae). Pour ce faire, un fractionnement bioguidé de la poudre a été réalisé. Le screening phytochimique a été réalisé par une méthode différentielle de coloration, de précipitation et par Chromatographie sur Couche Mince (CCM). Le test de sensibilité et la détermination des CMI et des CMF ont été évalués par la méthode de diffusion en milieu solide et la méthode de micro dilution en milieu solide et liquide. Les résultats de ce travail montrent que l'extrait aqueux a donné un plus grand rendement d'extraction avec 18,02%. Le criblage phytochimique de la poudre a montré une forte présence des tannins galliques, des saponosides, des anthocyanes, des flavonoïdes, des leuco-anthocyanes, des composés réducteurs, des mucilages et des dérivés cyanogéniques. La souche de référence *Candida albicans* a montré une sensibilité face aux extraits éthanoliques et aqueux à 20mg/ml. Le plus grand diamètre d'inhibition a été obtenu avec l'extrait aqueux (18,6 mm). La CMF des deux extraits est supérieure à la concentration testée. Néanmoins la croissance fongique diminue dans les boîtes de pétri au fur et à mesure que la concentration augmente. L'extrait aqueux par la présence des composés chimiques retrouvés pourraient justifier son action dans le traitement des mycoses. Des recherches supplémentaires sont en cours sur l'extrait aqueux de *Acalypha wilkesiana* afin d'explorer son potentiel thérapeutique à travers une formulation galénique appropriée et réaliser par ailleurs une activité in vivo sur les rats Wistar afin d'évaluer leur comportement face au candidat - médicament.

Mots clés : *Acalypha wilkesiana* ; activité antimycosique ; criblage phytochimique ; *Candida albicans*

IDENTIFICATION DE MEDICAMENTS COMBINES ARTEMETHER-LUMEFANTRINE A L'AIDE DE SPECTROSCOPIE INFRAROUGE MOYEN ET D'OUTILS CHIMIOMETRIQUES

Aristide A.S. ADJAGBONI¹, Patient H. CIZA², Moussa YABRE³, Engelbert AGBOKPONTO¹, Parfait DOFFON⁴, Ahmed AMOUSSA⁴, Loconon Y. Achille YEMOA^{1,4}, Christophe AMIN⁵

¹ Laboratoire de Chimie analytique et Analyse des Médicaments (LCAM), UFR Pharmacie, Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey Calavi, Cotonou, Bénin.

² Université de Kinshasa, Faculté des Sciences Pharmaceutiques (LACOMEDA), Lemba, 212 Kinshasa XI, RD Congo.

³ Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), Université Nazi BONI, Bobo- Dioulasso, 01 PO Box 1091, Burkina Faso.

⁴ Agence nationale de Contrôle de Qualité des produits de santé et de l'eau ; Ministère de la Santé ; 06 BP 139 Akpakpa-Donantin, Cotonou, Bénin.

⁵ Université de Cocody, UFR Sciences Pharmaceutiques, Laboratoire de Chimie Analytique, Chimie Minérale et Chimie Générale, BPV 34 Abidjan, République de Côte d'Ivoire.

Contact de l'auteur correspondant : Tél : +229 67003868 E-mail : aristideadjagboni@gmail.com

Problématique : la spectroscopie infrarouge moyen serait un moyen de détection rapide des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés

Objectif : Cette étude a pour but d'évaluer la capacité de la spectroscopie moyen infrarouge moyen (MIR) en association avec la chimiométrie, à identifier les médicaments combinés à base d'artémether et de luméfantrine et à pouvoir les discriminer.

Matériel et méthodes : La pré-enquête et le prélèvement d'échantillons s'est déroulé en conditions réelles d'achat dans le circuit formel des secteurs public et privé dans deux communes du sud Bénin : Cotonou et Abomey-Calavi. Au total, 46 échantillons de différentes marques ont été collectés : trente à base d'artémether/luméfantrine «AL», trois à base de dihydroartémisinine/pipéraquine et triméthoprime «DP», deux à base d'artésunate/sulfaméthoxypyrazine/pyriméthamine «AS», un à base de sulfate de quinine «QS» et quatre à base de sulfadoxine/pyriméthamine «SP».

Les analyses ont été réalisées à l'aide d'un spectrophotomètre moyen infrarouge à transformée de Fourier, dans la plage spectrale comprise entre 4000 et 650 cm⁻¹. Un pré-traitement et une analyse en composantes principales (ACP) a été appliquée. Une analyse d'authentification a été réalisée en utilisant le modèle chimiométrique DD-SIMCA.

Résultat : L'analyse en composantes principales (PCA) appliquée sur les données spectrales prétraités permettait de discriminer convenablement les spectres d'AL de ceux de toutes les autres molécules : AS, DP, QS, SP. Cependant, trois des échantillons présentaient des comportements atypiques car leurs scores étaient très différents des autres échantillons. Par conséquent, ces échantillons peuvent avoir une composition chimique (excipients) différente des autres échantillons. Ceci nous a amené à refaire le test sur le modèle DD-SIMCA.

Conclusion : Les résultats de cette étude préliminaire ont établi les premières preuves que la spectroscopie MIR présente un grand potentiel en tant qu'outil de dépistage utile et rapide pour détecter les médicaments falsifiés.

Mots-clés : Spectroscopie Infrarouge moyen, chimiométrie, contrôle de qualité, artémether/luméfantrine, DD-SIMCA

LES COMMIS DE PHARMACIE DANS LA LUTTE CONTRE LES HELMINTHIASES AU SUD-BENIN : ENTRE RECOMMANDATIONS OFFICIELLES ET PRATIQUES SOCIALES

:Atsou Afanyizou (1), Nathalie Hounghinih (2), Roch Hounghinih, (3)

1. Laboratoire d'anthropologie médicale appliquée, Université d'Abomey-Calavi

E-mail : afanyizouatsou@gmail.com

Tél : + 229 67 86 57 44

2. Laboratoire d'anthropologie médicale appliquée, Université d'Abomey-Calavi

E-mail : nathaliehounghinih61@gmail.com

Tél : + 229 61 35 81 55

3. Laboratoire d'anthropologie médicale appliquée, Université d'Abomey-Calavi

E-mail: roch_hounghinih2001@yahoo.fr

Tél: + 229 95 06 13 35/66 97 92 45

Dans les communes de Tori-Bossito et de Toviklin, pour contourner les dépenses de consultation dans les centres de santé et dans un contexte où l'offre illégale de médicaments ne se réduit qu'à des pratiques clandestines à cause de l'interdiction de la vente de médicaments de la rue au Bénin, les populations se tournent vers les officines de pharmacie où le premier point de contact est le commis. Ceci entraîne la demande et l'offre des médicaments sans prescription médicale et renforce les pratiques d'automédication qui contrastent avec les normes biomédicales. Cet article vise à analyser les représentations sociales du commis de pharmacie et les pratiques populaires induites. La recherche est de type ethnographique basée sur des entretiens semi-directifs auprès de 100 acteurs dans les deux communes, l'observation et la revue documentaire. Ces acteurs, de catégories diverses ont été identifiés par choix raisonné. La méthode de saturation a permis de définir leur taille. Les données collectées et enregistrées ont été retranscrites et analysées au moyen des techniques de triangulation, de tri thématique et de l'analyse de contenu. Les résultats montrent que, l'identité du commis est socialement construite. Il est perçu, au-delà de son rôle de distribution des produits pharmaceutiques, comme un professionnel qualifié ayant les compétences de prescription et de dispensation, à qui les clients expliquent leurs problèmes de santé et leurs besoins en informations. Dans le cadre de la gestion des helminthiases, les médicaments vermifuges courants sont considérés comme des génériques d'usage facile et sans risque. Les services de prescription et de dispensation sont sollicités auprès des commis qui répondent en fonction de leurs connaissances empiriques coexistant avec les connaissances théoriques, en lien avec leurs trajectoires socioprofessionnelles. Par ailleurs, ces derniers ont des connaissances limitées des helminthes, notamment des modes de traitement et de prise en charge. Il est important de revisiter, de renforcer et de mettre à jour les rôles de ces acteurs de bas dans le système pharmaceutique pour une promotion de comportements et de pratiques judicieuses de santé.

Mots clé : commis de pharmacie, normes et pratiques, helminthiases, représentations, Toviklin, Tori-Bossito.

PHYTOCHIMIE ET ACTIVITE ANTI BACTERIENNE DES COMBINAISONS DE DEUX PLANTES UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DE LA FIEVRE TYPHOÏDE

Ahouansou C. Ayidé*, Abissi F. Worou, Ohin M. Brice, Houngbèchè G. Alban et Assongba Faustin

Citrus aurantifolia et *Psidium guajava* sont deux plantes traditionnellement utilisées seules ou en combinaison dans le traitement de la fièvre typhoïde et d'autres maladies gastrointestinales. Pour confirmer les activités antibactériennes et déterminer une bonne efficacité desdites plantes, cinq cohortes (A: 100% *C. aurantifolia*; B: 100% *P. guajava*; C: 75% *P. guajava* + 25% *C. aurantifolia*; D: 75% *C. aurantifolia* + 25% *P. guajava* et E: 50% *C. aurantifolia* + 50% *P. guajava*) de poudres issues des feuilles desdites plantes ont été réalisées. Les extraits aqueux et hydro-éthanoliques de ces cohortes ont été préparés respectivement par décoction et macération dans un mélange d'eau et d'éthanol à 96% (4/6 ; v/v). Le criblage phytochimique a été réalisé par chromatographie sur couche mince et par des méthodes de coloration et de précipitation différentielles. L'activité antibactérienne des extraits a été réalisée par la méthode de diffusion sur gélose. La concentration minimale inhibitrice (CMI) et la concentration minimale bactéricide (CMB) ont été déterminées respectivement par des méthodes de microdilution sur microplaques et d'inoculation sur milieu solide. Les extraits aqueux et hydro-éthanolique de toutes les combinaisons de plantes à l'exception de la combinaison D, ont inhibé la croissance des souches de *Salmonella typhi*. La plus faible CMI est de 0,3125 mg/mL et a été obtenue avec l'extrait hydro-éthanolique de B et les extraits aqueux des combinaisons B et C. Les CMB des extraits testés sont toutes supérieures à 20 mg/mL avec une diminution de la croissance bactérienne au fur et à mesure que la concentration des extraits augmente. Il en résulte que la combinaison *Psidium guajava* et de *Citrus aurantifolia* (75/25, p/p) présente une bonne activité anti typhoïde et il s'avère nécessaire qu'une étude approfondie sur la toxicité desdites plantes ainsi que leur combinaison soit réalisée.

Mots-clés: *Citrus aurantifolia*, *Psidium guajava*, Fièvre typhoïde, Activité antibactérienne

CELLULITE FACIO-CERVICO-THORACIQUE ODONTOGENE CHEZ DES GESTANTES

ODONTOGENIC FACIOCERVICOTHORACIC CELLULITIS IN PREGNANT WOMEN

*Hounlelou VE, Lawson Afouda S, Medji S., do Santos Zounon A., Guézo D., Adjibabi W.,
Clinique universitaire d'ORL-CCF, CNHU-HKM. Cotonou*

La cellulite facio-cervico-thoracique chez la femme enceinte est une urgence médico-chirurgicale. Elle peut engager le pronostic materno-fœtal. Nous rapportons les différents contextes de survenue de cette pathologie à travers deux cas.

Observations

Obs 1 : Patiente de 25 ans, gestante de 29 SA admise pour une tuméfaction sous mentonnière. L'interrogatoire a retrouvé un début qui remonterait à deux semaines avant son admission par une douleur dentaire des quadrants 3 et 4 motivant une automédication par du diclofénac. À l'examen, l'état général était altéré, une gêne respiratoire à type de polypnée superficielle à 35 cycles, présence d'une fièvre à 39 degrés, une tachycardie et une désaturation. Localement, présence d'une tuméfaction sub-mentonnière gauche étendue à la région submandibulaire gauche et sus claviculaire gauche avec une fistulisation en région submandibulaire. L'examen de la cavité buccale a retrouvé un trismus à 1,5cm franchissable avec carie des 36,37 et 48. Mise sous amoxicilline acide clavulanique et du métronidazole et pansement. L'évolution marquée par une expulsion du fœtus, une exacerbation de la dyspnée et une altération de la conscience. Radiographie pulmonaire non faite à cause de l'état de la patiente. Elle a été transférée en réanimation. Décès au bout de 5 jours dans un tableau de médiastinite probable.

Obs 2 : Patiente de 29 ans, gestante de 24 SA admise d'emblée pour cellulite facio-cervico-thoracique. Début remonterait à 4 jours avant admission par une douleur dentaire du quadrant 3 motivant la prise de diclofénac. À l'examen, l'état général altéré, présence d'une fièvre à 40 degrés, une hypotension à 80/50 mm hg rebelle au remplissage vasculaire. Présence d'une tuméfaction facio-cervico-thoracique gauche, avec issue de pus en région sous mentale, L'examen de la cavité buccale retrouvait un trismus invincible. élargissement de la fistule et drainage. Antibiothérapie fait avec pansement et surveillance obstétricale. Décès survenu une semaine plus tard dans un tableau de choc septique.

Conclusion La cellulite facio-cervico-thoracique est d'autant plus grave qu'il existe une notion de prise d'anti-inflammatoire sur un terrain immunodéprimé, dans un contexte économique précaire. Evolution irréversible au décours d'un choc septique isolé ou associé et d'une médiastinite

Mots clés : Cellulite cervico-faciale- Immunodépression-antiinflammatoire

ASTHME DE L'ENFANT : CONNAISSANCES ET PRATIQUE DES PEDIATRES EXERÇANT AU BENIN EN 2023

Auteurs : Alihonou F^{1,3}, Yakoubou A^{2,3}, Badiou Y¹

1 : Service de pédiatrie du CNHU/HKM

2 : service de pédiatrie du CHU-MEL

3 : Faculté des Sciences de la santé de Cotonou

Auteur correspondant : ALIHONOU Florence

Email : florencealihonou@yahoo.fr Tel : 0022995952380

Introduction : maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires, l'asthme est de plus en plus fréquent en milieu pédiatrique. L'objectif de ce travail était d'évaluer les connaissances et la pratique des pédiatres sur l'asthme de l'enfant à Cotonou.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude observationnelle de type transversale, descriptive à visée évaluative avec un recueil prospectif des données. Elle s'était déroulée du 07 juillet au 18 août 2023. Tous les pédiatres exerçant au Bénin et ayant accepté de participer à l'enquête avaient été inclus. Les recommandations diagnostiques et thérapeutiques du Global Initiative For Asthma (GINA) et de la Haute Autorité de santé HAS avaient été utilisées comme référence.

Résultats : Sur les 170 pédiatres répertoriés, 83 avaient répondu au questionnaire, soit un taux de participation de 48,82%. On notait une prédominance féminine (sex-ratio : 0,57). La majorité des participants était des jeunes pédiatres avec une ancienneté professionnelle de moins de 10 ans. Tous associaient l'asthme à une pathologie allergique. Le score de PRAM déclaré connu dans 32,5%(n=27) n'était utilisé que par 8 pédiatres (29,63%). Il en était de même pour la classification GINA dite connue par 36 pédiatres (43,4%) mais utilisée par 14(38,89%). Le traitement de la crise d'asthme était connu par 92,77% des pédiatres. Ce taux baissait à 66,27% pour le traitement de fond. Le débitmètre et le spiromètre étaient cités comme outils de diagnostic par 63,86% et 40,96% des pédiatres. La spirométrie était utilisée par 34% et le débitmètre de pointe par 7,23%. Le traitement de fond n'avait été instauré que par 50,60% des pédiatres.

Conclusion : les connaissances et la pratique des pédiatres exerçant au Bénin en matière de prise en charge de l'asthme devraient être améliorées.

Mots-clés : asthme, pédiatre, connaissance, pratique, Cotonou, Bénin

SYNDROME CORONARIEN AIGU DU SUJET JEUNE AU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2023 : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, DIAGNOSTIQUES, THERAPEUTIQUES ET EVOLUTIFS

Zanda Vougo MMM, Nguimgo Ngoufack N, Melo GAT, Kondo Moussa R, Dossou CS, Yelouassi JD, Adjagba P, Hounkponou M, Sonou AD, Codjo LH

Affiliations :

Unité d'Enseignement et de Recherche en Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi(UAC)

Clinique Universitaire de Cardiologie, CNHU/HKM de Cotonou

Introduction : La maladie coronarienne chez le sujet jeune est rare, mais son incidence est en nette progression, surtout en Afrique sub-saharienne.

Objectif : Le but de notre étude était de décrire les aspects épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs du syndrome coronarien aigu (SCA) du sujet jeune à la Clinique Universitaire de Cardiologie (CUC/CNHU-HKM) de Cotonou.

Matériel et méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale et descriptive avec recueil prospectif de données, réalisée sur la période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 août 2022. Étaient inclus tous les patients d'âge ≤50 ans admis à la CUC pour SCA et ayant donné leur consentement éclairé.

Résultats : La prévalence du SCA du sujet jeune à la CUC était de 31,6%. L'âge moyen était de 40,8 ± 7,7 ans avec une nette prédominance masculine (87,1%). Le risque cardiovasculaire global était faible dans 48,3% des cas. Le SCA ST+ représentait 70,9% des cas. La majorité des patients était vue hors délais (58,1%). L'origine athéromateuse était la plus plausible pour la plupart des patients (96,7%). Sur cinq coronarographies réalisées, trois relevaient des lésions tritronculaires. Au moins une complication intra-hospitalière avait été observée chez 41,9% des patients. La mortalité hospitalière était de 3,2%.

Conclusion : La fréquence des SCA chez le sujet jeune est élevée à la CUC/CNHU-HKM de Cotonou. Les principaux facteurs de risque observés chez ces patients étaient modifiables. L'accentuation des mesures préventives et thérapeutiques devraient permettre de réduire la morbi mortalité liée à cette pathologie.

Mots clés : Syndrome coronarien aigu, sujet jeune, athérosclérose, Bénin

IDEES SUICIDAIRES CHEZ LES ETUDIANTS EN MEDECINE, PHARMACIE ET ODONTOSTOMATOLOGIE DES UNIVERSITES PUBLIQUES DU TOGO EN 2021

LEGBA AA, SOEDJE KM, ANAGONOU L

Auteur correspondant : LEGBA Adia Ariane Y. G. ; adia_ariane@hotmail.com; +22962201700

Le but principal de cette étude était d'évaluer la prévalence et les facteurs associés aux idéations suicidaires chez les étudiants en médecine des universités publiques en République Togolaise.

Il s'est agi d'une étude transversale auprès des étudiants de médecine, pharmacie et odontostomatologie des universités publiques du Togo, du 1er juillet au 30 septembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un questionnaire individuel en formulaire GoogleForm dont le lien a été partagé à travers des groupes WhatsApp préexistants. Les données ont été traitées par le logiciel EPI INFO version 7.2.5.0. Les facteurs associés ont été étudiés en analyse univariée et multivariée.

Un total de 587 étudiants de médecine, pharmacie et odontostomatologie ont été enquêtés. La plupart des étudiants étaient de sexe masculin (62,8%) et en première année de sciences médicales. La prévalence des idéations suicidaires était de 26,2%. Les facteurs associés aux idéations suicidaires étaient le sexe féminin, un résultat universitaire non satisfaisant, une mauvaise qualité des relations parentales, un manque d'activités sportives, le niveau de 1er cycle d'études médicales, la consommation d'alcool, la consommation de substances psychoanaleptique et psycholeptiques, et un antécédent de dépression. Les idéations suicidaires étaient indépendamment associées à la consommation d'alcool, de substances psycholeptiques et un antécédent de dépression.

Les idées suicidaires sont une réalité parmi les étudiants en médecine, pharmacie, et odontostomatologie des universités publiques du Togo et plusieurs facteurs influencent leur survenue.

Mots-clés : idées suicidaires, étudiants en sciences médicales, Togo

COMORBIDITE TROUBLE STRESS POST-TRAUMATIQUE ET CRISES FONCTIONNELLES DISSOCIATIVES : A PROPOS D'UN CAS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA EN 2024

LEGBA AA, DJAUGA S, HOUZE R, ANAGONOU L, ADJEN KC

Auteur correspondant : LEGBA Adia Ariane Y. G. ; adia_ariane@hotmail.com; +22962201700

Le Trouble Stress Post-Traumatique (TSPT) correspond à la survenue de symptômes caractéristiques à la suite de l'exposition à un événement traumatique. Les Crises Fonctionnelles Dissociatives (CFD), sont définies comme un événement paroxystique et involontaire caractérisé par un changement brutal et transitoire du comportement moteur, cognitif, émotionnel, sensoriel ou végétatif, pouvant être confondue avec une crise comitiale, sans préjuger de son étiologie. La cooccurrence entre les CFD et le TSPT est relativement fréquente. Nous présentons le cas d'une patiente de 21 ans, aux antécédents d'épilepsie structurale post traumatisme crânien, traitée depuis 2017, stabilisée avec rupture thérapeutique depuis un an. Elle a consulté dans le service de neurologie pour des crises épileptiformes ayant débuté 03 semaines avant admission, décrits comme des mouvements cloniques généralisés mais différents des anciennes crises. On ne retrouvait pas de morsure de la langue, d'amnésie post-critique, de respiration stertoreuse, de relâchement sphinctérien. Un EEG-vidéo a été demandé et la patiente a présenté au cours de l'enregistrement une crise sans anomalies paroxystiques retrouvée concomitamment sur le tracé. Ce tableau clinique a fait évoquer des CFD. Une évaluation psychiatrique demandée a retrouvé, au tableau clinique précédemment décrit, des antécédents d'agressions sexuelles subies par la patiente, un syndrome de répétition avec conduites d'évitement, hyperactivation neurovégétative et des altérations négatives des cognitions, des idées d'auto-culpabilité et des idées suicidaires passives. Le diagnostic d'une comorbidité TSPT et CFD a été retenu et la prise en charge a combiné traitement médicamenteux et psychothérapies. L'évolution a été marquée par une régression de la symptomatologie en 04 semaines. Ce cas met en lumière l'importance d'une évaluation complète incluant les aspects psychologiques devant des crises épileptiformes. Une approche thérapeutique intégrative améliore significativement les symptômes et la qualité de vie des patients.

Mots-clés: crises fonctionnelles dissociatives, trouble stress post-traumatique, psychotraumatisme

FACTEURS ASSOCIES AUX RECIDIVES DE POUSSEES DOULOUREUSES DE LOMBARTHROSE DANS LE SERVICE DE RHUMATOLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU

DJOSSOU J., LENOUMI G., AWANOU G., ZOMALHETO Z

Affiliation : Service de Rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou

Auteur correspondant : drhjuliend@yahoo.com, Tél 00229 97130572

Introduction : La lombarthrose est un problème majeur de santé publique dans le monde. Elle constitue le chef de fil des arthroses et est responsable de poussées douloureuses récidivantes.

Objectif : Cette étude avait pour objectif de déterminer les facteurs associés aux récidives de poussées douloureuses de lombarthrose chez les patients fréquentant le service de Rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou.

Patients et méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique portant sur les patients suivis depuis au moins un an dans le service de rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou pour lombarthrose. Etait considéré comme patient en récurrence de poussées douloureuses, tout patient qui faisait plus de 4 poussées douloureuses par an soit plus d'une poussée par trimestre.

Résultats : Sur les 386 patients reçus en consultation pendant la période d'étude, 102 (26,4%) présentaient des poussées douloureuses de lombarthrose. L'âge moyen de ces derniers était de $59,5 \pm 0,6$ ans avec un sex-ratio (H/F) de 0,21. L'indice de masse corporelle (IMC) était de $29,96 \pm 1,1$ Kg/m². L'âge ($p=0,012$), le surpoids et l'obésité ($p=0,04$), le stress ($p=0,03$), le soulèvement de charge ($p=0,000$), l'abaissement ($p=0,000$), la position debout prolongée ($p=0,014$), la position assise prolongée ($p=0,01$) étaient statistiquement associés aux récurrences de poussées douloureuses de lombarthrose. Le repos ($p=0,000$), la marche ($p=0,015$), la montée et la descente des escaliers ($p=0,019$) et le redressement ($p=0,005$) étaient plutôt des facteurs protecteurs.

Conclusion : Dans notre étude, les récurrences de poussées douloureuses de lombarthrose étaient associées à des facteurs de risque modifiables et non modifiables. Des mesures préventives contre les facteurs de risque modifiables s'imposent afin de limiter ces poussées douloureuses.

Mots clés : Lombarthrose, poussée douloureuse, récurrence

LES PATHOLOGIES MECANIQUES NON TRAUMATIQUES DU RACHIS DORSAL DANS LE SERVICE DE RHUMATOLOGIE CNHU-HKM DE COTONOU

Lenoumi G, Djossou J, Affedjou E, Dossu-Yovo H, Badirou F, Boton M, Djaho D, Salam D, Zomalheto Z

Service de rhumatologie (CNHU-HKM de Cotonou)

INTRODUCTION Dans la sous-région peu d'études se sont consacrées aux pathologies mécaniques non traumatique du rachis dorsal. L'objectif de ce travail était d'étudier les aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques des pathologies mécaniques non traumatiques du rachis dorsal dans le service de rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou.

PATIENTS ET METHODES Il s'agissait d'une étude transversale descriptive qui s'est déroulée dans l'unité de rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou. Ont été colligés les dossiers du 01 janvier 2018 au 31 Décembre 2022 des patients admis pour dorsalgies mécaniques non traumatiques. Les données ont été analysées par Excel 2020.

RESULTATS Cents dix-sept (117) dossiers de patients présentant des pathologies mécaniques non traumatiques du dos ont été vus sur les quatre mille six cents six (4606) dossiers de la période d'étude soit une fréquence hospitalière de 2,5 %. L'âge moyen était de $49,6 \pm 2,1$ ans [12 et 88 ans]. Le sex-ratio était de 0,43. Le début était progressif et l'évolution était chronique dans 100 % des cas. La douleur était d'intensité modérée dans 88,9 % des cas. Elle était à type de striction (75,2 %), de brûlure (18,8 %), de crampe (3,42 %), de décharge électrique (0,9 %) et de torsion (1,7 %). L'Indice de Masse Corporel (IMC) moyen était de $27,5 \pm 0,7$ Kg/m² [16,9 et 51,5 Kg/m²]. À la radiographie on retrouvait des lésions ostéophytiques (36,8 %) et le pincement discal (30,8 %). La pathologie fréquente était la dorsarthrose (35,9 %) suivie des troubles statiques (27,4 %). Au plan thérapeutique, tous les patients ont bénéficié du traitement antalgique, myorelaxant et des conseils d'hygiène du dos. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) étaient prescrits en l'absence de contre-indication (94 %). L'évolution était favorable avec rémission dans 94,9 % des cas.

CONCLUSION Dans le service de rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou, les pathologies mécaniques non traumatiques du rachis dorsal sont fréquentes. Elles sont essentiellement représentées par la dorsarthrose et les troubles statiques. L'évolution sous traitement est souvent favorable.

Mots clés : Pathologies mécaniques non traumatiques, rachis dorsal, CNHU-HKM de Cotonou

FACTEURS ASSOCIES AUX RECIDIVES DE POUSSEES DOULOUREUSES DE GONARTHROSE DANS LE SERVICE DE RHUMATOLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU

DJOSSOU J., LENOUMI G., AWANOU G., ZOMALHETO Z

Affiliation : Service de Rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou

Auteur correspondant : drhjuliend@yahoo.com, Tél 00229 97130572

Introduction : La gonarthrose est un motif fréquent de consultation en rhumatologie. Elle peut devenir invalidante lorsque les poussées douloureuses ou congestives deviennent répétitives.

Objectif : Cette étude avait pour objectif de déterminer les facteurs associés aux récurrences de poussées douloureuses de gonarthrose chez les patients fréquentant le service de Rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou.

Patients et méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique portant sur les patients suivis depuis au moins un an dans le service de rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou pour gonarthrose. Etait considéré comme patient en récurrence de poussées douloureuses, tout patient qui faisait plus de 4 poussées douloureuses par an soit plus d'une poussée par trimestre.

Résultats : Sur les 386 patients reçus en consultation pendant la période d'étude, 77 (19,9%) présentaient des poussées douloureuses de gonarthrose. L'âge moyen de ces derniers était de $61,69 \pm 1,2$ ans avec un sex-ratio (H/F) de 0,04. L'âge ($p=0,013$), le sexe ($p=0,005$), le surpoids et l'obésité ($p=0,014$), le stress ($p=0,02$), la montée et la descente des escaliers ($p=0,000$), le soulèvement de charges lourdes ($p=0,000$), l'abaissement ($p=0,000$), la position debout prolongée ($p=0,000$), la position assise prolongée ($p=0,012$), le port de chaussures hautes ($p=0,01$) étaient statistiquement associés aux récurrences de poussées douloureuses de gonarthrose. Par contre, le repos ($p=0,005$), la marche ($p=0,000$) et le redressement ($p=0,002$) constituaient des facteurs protecteurs.

Conclusion : Notre étude montre que les récurrences de poussées douloureuses de gonarthrose sont associées à des facteurs personnels et comportementaux confirmant ainsi d'autres études. Il importe donc de prévenir ces récurrences modifiant les facteurs de risques comportementaux.

Mots clés : gonarthrose, poussée douloureuse, récurrence

ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES ET PRONOSTIQUES DES AVC DE LA FOSSE CRANIENNE POSTERIEURE EN USINV AU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2023

Toviwanou R, Houeze R, Balley G, Gnonlonfoun D, Adjien K

Introduction : Les AVC de la fosse cérébrale postérieure sont graves du fait de leur localisation. Peu de données béninoises. L'objectif de ce travail était d'étudier les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques et pronostiques des AVC de la fosse cérébrale postérieure en USINV au Bénin en 2023

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale rétrospective à visée descriptive du 1^{er} Septembre 2022 au 31 Juillet 2023 et ayant porté sur les sujets hospitalisés en Unité de Soins intensifs Neuro-vasculaire (USINV) pendant la période d'étude, avec une imagerie cérébrale confirmant le diagnostic. Les informations ont été collectées, saisies et analysées grâce aux logiciels Kobocollect, SPSS version 19.

Résultats : Au total, 307 patients étaient admis. 20 patients présentaient un AVC confirmé de la fosse cérébrale postérieure soit une fréquence hospitalière de 8,81%. Le sexe ratio était de 2,33 avec 70 % d'hommes. L'âge moyen était de 51 ans. Le délai moyen d'admission des patients à l'USINV après le déficit était de 112,7 heures+/- 163. L'HTA était le facteur de risque le plus fréquent à 80%. Le score NIHSS moyen était bas à 4,55. 45% des patients avaient fait un AVC ischémique. On y distinguait 35% d'AVCI du tronc basilaire et 10% d'AVC du cervelet. Les AVC hémorragiques quant à eux prédominaient surtout au niveau du cervelet (45%). Les AVC de la fosse postérieure représentaient ainsi 5,55% de tous les décès survenus en USINV.

Conclusion : Les AVC de la fosse cérébrale postérieure ont un pronostic grave avec nécessité de prise en charge précoce en USINV.

Mots clés : AVC, Tronc cérébral, cervelet, NIHSS, décès

HANDICAP PHYSIQUE ET INDEPENDANCE FONCTIONNELLE EN POST-ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE NEUROLOGIE DU CNHU-HKM EN 2022 : ETUDE DE PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIÉS.

HOUZE R, AGBETOU-HOUESSOU M, FATON A, DJAUGA S, COVI R, ADJEN A, TOVIWANOU R, BALLEY G, AVOCE M, ADJEN KC

Introduction : L'AVC constitue un véritable problème de santé publique à travers le monde. Le lourd fardeau que porte les patients est surtout leur dépendance fonctionnelle qui altère irrémédiablement leur qualité de vie. L'objectif de notre étude était d'évaluer la prévalence du handicap physique et de l'indépendance fonctionnelle en post-AVC dans la Clinique Universitaire de Neurologie du CNHU- HKM en 2022 et d'en rechercher les facteurs associés. **Méthodes d'étude**

: il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et analytique qui s'est déroulée du 25 Juillet au 28 Octobre au CNHU. Nous avons fait un recrutement exhaustif de tous les patients ayant fait un AVC datant d'au moins un mois et qui ont consulté pendant cette période d'étude en neurologie.

Résultats : Sur les 77 patients inclus, l'âge moyen était de 57,74ans (30 et 87 ans). La tranche d'âge des [50-69 ans] était la plus représentée (46%). Le sex-ratio était de 1,49. On notait 84,42% de handicap dont 53,25% de handicap léger, 20,78% de handicap moyen et 10,39% de handicap sévère. 55,55% des patients étaient dépendants dont 15,58% de dépendance légère, 32,47% de dépendance modérée, 5,19 % de dépendance sévère et 1,30% de dépendance totale. La reprise des activités socio-professionnelles, l'impact du handicap sur le niveau social, le type d'AVC, la rééducation fonctionnelle, le niveau de sévérité de l'AVC, le niveau d'indépendance fonctionnelle, la qualité de vie et la dépression étaient significativement associés au handicap alors que la reprise des activités socio-professionnelles, la rééducation fonctionnelle, le niveau de sévérité de l'AVC, le handicap, le degré d'autonomie étaient associés significativement à l'indépendance fonctionnelle.

Conclusion : Cette étude a révélé que le handicap, le degré de sévérité de l'AVC sont autant de paramètres mesurables qui altèrent l'indépendance fonctionnelle des survivants d'AVC.

Mots clés : AVC - handicap physique - Indépendance fonctionnelle - Bénin.

PREVALENCE ET FACTEURS DETERMINANTS DE TROUBLES ANXIO-DEPRESSIFS CHEZ LES LOMBALGIQUES CHRONIQUES AU CNHU-HKM DE COTONOU

EZIN G, AZA-GNANDJI G-G, JOGUE F A, KLIKPO T E E, ZOMALHETO Z C, EZIN HOUNGBE J.

Auteur correspondant : Ghislain EZIN ; Adresse mail : ezin.ghislain@gmail.com

La lombalgie chronique représente une charge énorme pour le système de santé, un défi de santé publique. Les troubles anxio-dépressifs sont fréquents dans la lombalgie chronique et l'influencent considérablement. L'objectif de notre étude a été d'analyser la prévalence et les facteurs déterminant les troubles anxio-dépressifs chez les patients atteints de lombalgie commune chronique au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou MAGA (CNHU-HKM) de Cotonou.

Il s'est agi d'une étude prospective transversale allant du 06 Janvier au 29 Juillet 2015, et portant sur tous les patients souffrant de lombalgie commune chronique suivis dans le service de rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou. Ces patients ont été soumis à un questionnaire comportait les échelles de Hamilton pour l'anxiété et de Beck pour la dépression.

La fréquence hospitalière de la lombalgie commune chronique était de 25,9%. La fréquence des troubles anxio-dépressifs chez ces patients se répartissait comme suit : troubles anxieux 65% ; trouble dépressifs 57% ; troubles anxieux et dépressifs associés 48%. Les composantes déterminantes des troubles anxieux étaient l'humeur anxieuse (90,8%), les troubles intellectuelles cognitives (87,7%) et l'humeur dépressive (86,1%) tandis que les troubles dépressifs étaient majoritairement exprimés par la fatigabilité (94,7%) et le besoin d'effort physique supplémentaire pour travailler (89,5%). Le sexe, l'insomnie, le niveau socio-économique et professionnel, l'assistance financière, l'intensité de la douleur lombaire, et la courte raideur lombaire matinale étaient les principaux facteurs associés à la survenue des troubles anxio-dépressifs avec respectivement $p=0,008$, $p=0,007$, $p=0,016$, $p=0,001$, $p=0,002$ et $p=0,008$.

La fréquence des troubles anxio-dépressifs chez les patients souffrant de lombalgie commune chronique est élevée comme noté dans la littérature. Leur prise en compte dans le traitement de ces patients dans leur globalité, améliorerait durablement leur qualité de vie et diminuerait les répercussions importantes de cette pathologie sur la société surtout africaine.

Mots-clés : Anxiété, dépression, lombalgie commune chronique, Bénin.

DEPRESSION DU POST-PARTUM CHEZ LES ACCOUCHEES DES CENTRES DE SANTE DE LA COMMUNE D'ABOMEY EN 2024

KLIKPO E¹, AGBAHOUNGBA JG², AZA GNANDJI GG¹, SALAMI L², SOPOH G

1- Clinique universitaire de santé mentale, CNHU-HKM, Cotonou, Bénin

2- Institut régional de santé publique, Ouidah, Bénin

Auteur correspondant : Elvyre KLIKPO Email : eklikpo@gmail.com

La dépression du post-partum est un trouble de l'humeur qui touche certaines femmes après l'accouchement. Souvent méconnue et sous-estimée, elle peut avoir des conséquences importantes sur la santé mentale de la mère et sur le développement de l'enfant. L'objectif de cette recherche était d'étudier les déterminants de ce trouble psychique chez les accouchées fréquentant les centres de santé de la commune d'Abomey.

Il s'agissait d'une étude transversale analytique, réalisée entre le 20 mars et le 5 avril 2024. La population d'étude était composée des accouchées de trois mois au moins fréquentant les centres de santé d'Abomey. Après une sélection aléatoire des centres de santé, toutes les accouchées éligibles ont été enquêtées à l'aide d'un questionnaire. L'échelle de dépression postnatale d'Édimbourg a été utilisée pour dépister la dépression du post-partum. Les données ont été analysées avec STATA 15.

Parmi les 440 accouchées interrogées, 75 (17,05 %) ont été identifiées comme déprimées. Les facteurs associés à cette prévalence étaient l'âge (aOR=6,73 ; IC=[1,66-27,20] ; p=0,007), la situation matrimoniale (aOR=43,28 ; IC=[4,10-457,21] ; p=0,002), le pouvoir de décision dans le ménage (aOR=1,87 ; IC=[1,06-3,31] ; p=0,031), la grossesse non désirée (aOR=3,40 ; IC=[1,93-5,99] ; p=0,000), le nombre de visite postnatale (aOR=1,44 ; IC=[1,02-2,02] ; p=0,038) et l'absence de prestations de soins relatifs à la dépression du post-partum.

Des facteurs socio-démographiques, gynéco-obstétricaux, liés aux expériences de l'accouchement et au système de santé influencent la survenue et la persistance de la dépression du post-partum chez les accouchées fréquentant les centres de santé d'Abomey. Il est nécessaire que les soins de santé mentale soient intégrés dans le paquet de soins à la mère au Bénin.

Mots clés : dépression du post-partum, facteurs associés, accouchées, Abomey.

FREQUENCE ET FACTEURS ASSOCIES AUX DECES NEONATAUX A L'HOPITAL SAINT JEAN DE DIEU DE BOKO EN 2023

Kpanidja MG, Agbeille Mohamed F, Hozanhékpon M, Noudamadjo A, Adédémý JD, Agossou J.

Département Mère-Enfant Faculté de Médecine, Université de Parakou (Bénin)

Auteur correspondant : KPANIDJA Mèdétinmè Gérard

Adresse : 03BP369 Parakou ; Tel 00229 96967994/94543195 ; Email : m.kpanidja@yahoo.ca

Introduction : Les décès néonataux constituent un problème de santé publique. L'identification des facteurs associés peut permettre d'impacter la mortalité néonatale. L'objectif de ce travail était d'étudier la fréquence et les facteurs associés aux décès néonataux à l'hôpital Saint Jean de Dieu de Boko en 2023.

Patients et méthodes : cette étude s'est déroulée à l'hôpital Saint Jean de Dieu de Boko. Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive. Elle avait concerné les dossiers de nouveau-nés admis et décédés du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Résultats

Au total 530 dossiers de nouveaux nés avaient été enregistrés. L'âge moyen des mères des nouveaux nés était de 26,13 ans $\pm$ 6,02 ans, avec des extrêmes de 15 ans à 43 ans. Nous avons enregistré 69 décès de nouveau-nés soit une fréquence de 13,02%. Les causes directes de décès étaient représentées par l'asphyxie périnatale 37 (53,62%) les infections néonatales 26 (37,37%) la détresse respiratoire 22 (31,88%) la prématurité 15 (21,73%). Les facteurs statistiquement associés aux décès néonataux étaient : la réanimation ($p < 0,001$), les scores d'APGAR à la 1ère et 5ème Minutes ($p < 0,001$), lieu de résidence ($p = 0,0113$), lieu d'accouchement ($p < 0,001$), et le mode d'accouchement ($p < 0,001$).

Conclusion : la prise en compte de ces facteurs de risque pourrait améliorer la survie des nouveau-nés

Mots clés : nouveau-nés, mortalité, facteurs, Boko, Bénin.

Introduction : L'Épilepsie est une affection neurologique chronique, ubiquitaire et universelle qui n'est pas encore bien connue dans le monde. L'objectif principal de ce travail était d'évaluer les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des pharmaciens d'officine sur l'épilepsie au Bénin en 2023. **Méthodes** : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive et analytique qui a porté sur 93 pharmaciens d'officine sur tout le territoire béninois durant deux mois allant du 10 Août au 15 Octobre 2023. Les variables qualitatives ont été décrites en utilisant les pourcentages et les quantitatives par une moyenne et un écart-type. Les niveaux de connaissance, d'attitude et pratiques ont été évalués grâce à un score CAP établi selon trois modalités : faible pour un score inférieur à 50%, intermédiaire pour un score compris 50 et 80%, et élevé quand le score est supérieur à 80%. Les données ont été analysées avec la version 2.0 du logiciel SPSS. **Résultats** : L'âge moyen était de 33,99 +/- 12,48 ans et le sexe ratio était de 1,16 en faveur des hommes. 87,1% des enquêtés avaient un score CAP global Intermédiaire et aucun pharmacien n'avait de score CAP global élevé. Il n'y avait pas de différence significative sur le score CAP entre le sexe, l'âge, le lieu d'exercice, le lieu de formation et la durée d'exercice. **Conclusion** : Aucun pharmacien n'a eu un niveau de connaissances élevé sur l'épilepsie mais les attitudes et pratiques étaient bonnes. Il n'y avait pas de facteurs associés à ce degré de connaissances, d'attitudes et pratiques des pharmaciens d'officine au Bénin.

Mots-clés : Epilepsie - CAP - Pharmaciens - Bénin

APPORT DE L'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE DANS LE DIAGNOSTIC DES TUMEURS CEREBRALES AU CNHU-HKM DE COTONOU : A PROPOS DE 158 CAS

WHENU SPU¹, AYI MEGNANGLO CA¹, ADJADOHOUN SBMG¹, ADJANAYO AS², YEKPE AHOUANSSOU HP¹.

¹ : centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM)

² : centre hospitalier universitaire départemental du Borgou (CHUD-B)

WHENU SPU : whenusena@gmail.com, Cotonou-Bénin, +229 64207570

Introduction : les tumeurs cérébrales posent de nombreux problèmes diagnostiques. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) occupe une place importante dans la démarche diagnostique permettant d'en faire un diagnostic topographique exhaustif. L'objectif de cette étude est de décrire l'apport de l'IRM dans le diagnostic des tumeurs cérébrales.

Matériels et méthodes : étude descriptive à collecte rétrospective sur une période de 34 mois allant de Juin 2021 à Mars 2024. Était inclus tout patient ayant réalisé une IRM et dont la symptomatologie clinique se rapportait à une atteinte tumorale cérébrale. Les variables étudiées étaient les types d'examen d'IRM réalisés, les indications, les spécialités des prescripteurs, le type de lésions tumorales retrouvées ou non, les territoires d'atteintes et les lésions associées.

Résultats : ont été colligés cent cinquante-huit (158) patients avec une moyenne d'âge de 45,35 ans [02 – 87 ans] et une sexe ratio de 0,44. Le service prescripteur le plus fréquent était la neurologie (24,68%). Les principales indications retrouvées étaient les bilans de réévaluation de tumeurs cérébrales connues (34,81%) suivis des céphalées (6,32%).

On dénombrait 38 cas (24,05%) d'adénomes hypophysaires, 25 cas (15,82%) de tumeurs gliales, 22 cas de méningiomes (13,92%) et 18 cas (11,39%) de tumeurs kystiques. Les localisations frontale (11,39%) et temporale (8,22%) étaient les plus fréquentes. Les principales lésions associées étaient l'engagement cérébral (15,18%), l'hydrocéphalie (10,75%) et l'atrophie corticale (8,86%).

Conclusion : l'IRM a été contributive et a permis de faire un bilan lésionnel exhaustif.

Mots clés : IRM, Tumeurs cérébrales, Cotonou.

CONTRIBUTION DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE COTONOU À LA RECHERCHE SUR LES PLANTES MÉDICINALES ENTRE 2006 ET 2022

CO25

Habib GANFON^{1,2}, Hanniel HOUETO¹, Gabin ASSANHOUE², Gérard DOSSOU AGOIN¹, Fernand GBAGUIDI³,

- 1) Centre de Recherche et de développement du Médicament PharmaLab (CRDM-PharmaLab) /Unité de Recherche en Pharmacognosie et Phytothérapie, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou -BENIN.
- 2) CRDM-PharmaLab /Unité de recherche en Pharmacie Galénique Industrielle, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou –BENIN
- 3) CRDM-PharmaLab / Unité de Recherche en Chimie Organique et chimie pharmaceutique, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou -BENIN

Introduction : L'une des missions assignées à la Faculté des Sciences de la santé (FSS) de Cotonou à travers l'UFR Pharmacie, était entre autres de promouvoir la recherche dans le domaine des plantes médicinales. Après plus de deux décennies d'existence de cette UFR, il apparaissait pertinent d'évaluer cette contribution à la valorisation des plantes médicinales. **Méthodologie :** Une étude rétrospective descriptive a été effectuée sur la période allant de décembre 2022 à Juin 2023. Elle s'est appuyée sur la revue documentaire des thèses d'exercice de pharmacie et de médecine portant sur les plantes médicinales et soutenues à la FSS de Cotonou sur la période 2006-2022. Les données ont été collectées au moyen d'une grille d'analyse structurée pour recueillir les données biblio-thématiques et des données en lien avec la description des travaux réalisées ainsi que des plantes étudiées. **Résultats :** Sur 99 thèses en lien avec les plantes médicinales recensées soit 6,67% des thèses soutenues entre 2006 et 2022, 78 étaient des thèses de pharmacie et 21 de médecine. 186 plantes médicinales ont été répertoriées dans les différentes thèses, réparties dans 66 familles avec les Fabacées regroupant le plus grand nombre de plantes étudiées (n=40) et les feuilles représentaient la drogue la plus étudiée des espèces végétales (n=154 plantes). *Uvaria chamae* (n=9 thèses), *Garcinia kola* (n= 8 thèses) et *Xylopi aethiopica* (n= 8 thèses) étaient les espèces végétales les plus fréquemment étudiées. Les groupes de métabolites secondaires les plus mis en évidence dans les espèces végétales sont les flavonoïdes, les saponosides et les alcaloïdes. La majorité des travaux réalisés concernait l'évaluation d'activités biologiques (n=68 thèses) principalement sous forme des tests *in vivo* (n= 33 thèses), et des tests *in vitro* (n= 23 thèses) et d'études cliniques (n=12 thèses). Ces travaux ont concerné autant des problématiques prioritaires de santé comme l'hypertension artérielle (n=17 thèses), le paludisme (n=14 thèses) et le diabète (n=11 thèses) mais aussi des pathologies plus négligées comme la drépanocytose (n= 2 thèses) permettant ainsi d'établir un répertoire des plantes ayant démontré une activité dans chacune de ces pathologies. **Conclusion :** La contribution de la FSS à la recherche sur les plantes médicinales est significative et l'étendue de ses capacités ouvre des perspectives intéressantes pour la production de phytomédicaments efficaces et sûres pour les populations. **Mots-clés :** FSS, Pharmacie, Médecine, plantes médicinales, phytomédicaments

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES TISANES REPUTES AMAIGRISSANTES, COMMERCIALISEES A COTONOU ET ABOMEY-CALAVI

CO26

Habib GANFON^{1,3}, Camille PANDZA^{1,2}, Gérard DOSSOU AGOIN¹, Gabin ASSANHOU³, Engelbert AGBOKPONTO², Parfait DOFFON^{2,3}, Achille YEMOA²

- 1) Centre de Recherche et de développement du Médicament PharmaLab (CRDM-PharmaLab) /Unité de Recherche en Pharmacognosie et Phytothérapie, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou -BENIN.
- 2) CRDM-PharmaLab /Unité de recherche en Pharmacie Galénique Industrielle, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou –BENIN
- 3) CRDM-PharmaLab / Unité de Recherche en Chimie Organique et chimie pharmaceutique, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou -BENIN

L'obésité représente un véritable problème de santé publique qui a favorisé l'émergence sur le marché des tisanes à base de plantes réputées amaigrissantes, commercialisées en libre accès et en l'absence de tout contrôle. De ce fait, leur utilisation inappropriée sur la durée peut être à l'origine d'effets indésirables sévères. D'où l'objectif de cette étude visant à évaluer la qualité de ces tisanes commercialisées à Cotonou et à Abomey-Calavi. Matériels et méthodes Une étude transversale descriptive et analytique s'est faite de Février à Septembre 2024. Les échantillons ont été collectés par méthode non probabiliste dans des pharmacies, supermarchés, salles de sport et herboristeries. Les tests incluent ceux d'identification (caractérisation phytochimique), de pureté (perte à la dessiccation) ainsi que le dosage des principes actifs, réalisés conformément aux méthodes des pharmacopées Européenne et Britannique. Résultats et discussion Sur 50 tisanes collectées, dont 60% dans les supermarchés entre Cotonou et Calavi, aucune des tisanes n'était conforme au regard de l'analyse pharmaco-réglementaire. 19/50 des références provenaient d'Afrique dont la majorité du Bénin soit 38%. 90 plantes ont été recensées appartenant à 42 familles botaniques différentes. Les espèces les plus représentées étaient *Camellia sinensis* (11,65%), *Senna sp* (9,22%), *Nelumbo nucifera* (3,88%). Les principales familles étaient les Fabaceae (16,50%), Theaceae (11,65%), Lamiaceae (7,28%). Les principales drogues végétales mentionnées étaient les feuilles (32/77 soit 41,56%), graines (20/77 soit 25,97%) et fleurs (8/77 soit 10,39%). Les échantillons comprenaient majoritairement des recettes associant 6 plantes (12/50 soit 24%), 3 plantes (10/50 soit 20%) et 4 plantes (8/50 soit 16%). 6 échantillons/50 présentaient une teneur en eau > 10%. Le criblage phytochimique réalisé a montré la présence de métabolites secondaires laxatifs tels les mucilages (47/50 soit 94%) et anthracénosides (27/50 soit 54%). En ce qui concerne les anthracénosides, 18 échantillons/20 ont des teneurs comprises dans l'intervalle [0.542%-2.859%].

Conclusion Les tisanes amincissantes commercialisées à Cotonou et Abomey-Calavi présentent des non-conformités du point de vue réglementaire et renferment pour certaines, des composés laxatifs dont l'usage détourné peut être à l'origine d'effets indésirables sévères.

Mots-clés : obésité, tisanes amincissantes, qualité, non-conformité, profil réglementaire, toxicité.

ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ CYTOTOXIQUE DE TROIS PLANTES DE LA PHARMACOPÉE BÉNINOISE

Axel AHOUANSON^{1,2,3,4}, Habib GANFON¹, Célia DECHAVANNE², Callinice CAPO-CHICHI³, Latifou LAGNIKA⁴, Agnès AUBOUY², Achille MASSOUGBODJI².

1) Laboratoire de Pharmacognosie et Phytothérapie, Université d'Abomey-Calavi, Campus du Champ de Foire, 01 BP 188, Cotonou, Bénin

2) Institut de Recherche Clinique du Bénin, 04 BP 1114, Abomey-Calavi, Bénin

3) Laboratoire des Biomarqueurs Moléculaires en Cancérologie et Nutrition, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

4) Laboratoire de Biochimie et des Substances Naturelles Bioactives, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

Introduction Les maladies cancéreuses en recrudescence dans le monde, sont à l'origine d'environ 10 millions de décès en 2020. Leur traitement souvent onéreux, en plus de présenter des effets indésirables importants, est parfois inaccessible dans notre pays. Pour y remédier les plantes médicinales représentent une importante piste d'exploration pour de nouveaux agents thérapeutiques. La présente étude avait pour objectif d'évaluer l'activité cytotoxique d'*Annona muricata*, de *Momordica charantia* et de *Launaea taraxacifolia*, plantes de la pharmacopée béninoise réputées anticancéreuses. **Matériels et méthodes** Les feuilles d'*Annona muricata*, de *Launaea taraxacifolia*, et les plants entiers de *Momordica charantia* ont été collectés à Abomey (Département du Zou), localité située au sud du Bénin. Les extraits des plantes ont été obtenus à partir des drogues végétales, par décoction aqueuse et par extraction séquentielle avec des solvants de polarité croissante (dichlorométhane, acétate d'éthyle, méthanol). Les profils phytochimiques des extraits ont été déterminés par la méthode de Wagner et Bladt. La cytotoxicité des extraits a été évaluée sur des cellules cancéreuses de type THP-1 et sur des cellules normales de type PBMC. Après traitement par les extraits, la viabilité des cellules a été mesurée par cytométrie en flux après marquage au Thiazole Orange et au Hoechst 33258. **Résultats** Les fractions dichlorométhaniques d'*Annona muricata* et *Momordica charantia*, et celles d'acétate d'éthyle de *Momordica charantia* et *Launaea taraxacifolia* ont démontré des effets cytotoxiques significatifs sur les cellules THP-1. Leurs concentrations médianes inhibitrices (IC₅₀) étaient respectivement égales à 139,6 µg/ml, 72,89 µg/ml, 81,88 µg/ml et 106,3 µg/ml. De plus, ces extraits ont fait preuve d'une bonne sélectivité vis-à-vis des cellules normales. Le criblage phytochimique a quant à lui mis en évidence la présence d'alcaloïdes, de coumarines, de flavonoïdes, d'hétérosides anthracéniques, et de triterpènes dans les extraits actifs. **Conclusion** La présente étude a permis de démontrer le potentiel cytotoxique de trois plantes de la pharmacopée béninoise. Ces dernières pourront faire l'objet d'études ultérieures afin d'aboutir à terme, à la mise au point de nouveaux traitements anticancéreux. **Mots clés** : Cancer, THP-1, cytotoxicité, cytotoxicité sélective, extraits de plantes, Bénin.

IDENTIFICATION DES FALSIFICATIONS AUX ANTALGIQUES ET ANTI-INFLAMMATOIRES USUELS DANS DES PHYTOMÉDICAMENTS RÉPUTÉS ANTIDOULEURS ET COMMERCIALISÉS A COTONOU ET ABOMEY-CALAVI

Habib GANFON^{1,3}, Borrel BIAOU^{1,2}, Engelbert AGBOKPONTO², Gabin ASSANHOU³, Parfait DOFFON², Gérard DOSSOU AGOIN¹, Achille YEMOA²,

- 1) Centre de Recherche et de développement du Médicament PharmaLab (CRDM-PharmaLab) /Unité de Recherche en Pharmacognosie et Phytothérapie, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou -BENIN.
- 2) CRDM-PharmaLab /Unité de recherche en Pharmacie Galénique Industrielle, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou -BENIN
- 3) CRDM-PharmaLab / Unité de Recherche en Chimie Organique et chimie pharmaceutique, EDSS/ UAC, 01BP188 Cotonou -BENIN

Selon l'OMS, la falsification des médicaments conventionnels représenterait 10% du marché mondial en 2018. A l'instar des médicaments conventionnels objet de contrefaçons, les phytomédicaments également ne sont pas épargnés. Cette pratique pouvant être à l'origine de toxicité du fait de ces phytomédicaments falsifiés. Cette étude avait pour objectif de rechercher les falsifications aux antalgiques et antiinflammatoires usuels dans les phytomédicaments commercialisés comme antidouleurs au Bénin.

Matériels et méthodes : Notre étude s'est déroulée dans les communes de Cotonou et Abomey-Calavi et a porté sur les phytomédicaments présentés comme possédant une action contre la douleur. Après la collecte, différents tests ont été réalisés entre autres : l'analyse pharmaco réglementaire, l'uniformité de masse et de volume, les tests de désagrégation, la mesure du pH et l'identification par CCM en présence de standards de référence.

Résultats et discussion : Au total 40 échantillons ont été collectés dans les limites de la zone d'étude dont 07 sous forme de gélules, 25 pommades, 04 crèmes et 04 solutions buvables. Il s'est agi d'un échantillonnage par commodité. Il ressort de l'analyse que 47,5% des échantillons étaient fabriquées au Bénin, 32,5% d'origine variée et 20% d'origine inconnue. Au total 87,5% des échantillons ne disposaient pas d'une autorisation de commercialisation ; 100% des échantillons avaient un conditionnement primaire et 10% un conditionnement secondaire. Seulement 32,5 % des échantillons renseignaient sur leur composition qualitative et contenaient pour la majorité de l'eucalyptus, du camphre, de l'aloès, du moringa, du capsicum. 85,71% des gélules ont satisfaits aux tests d'uniformité de masse et de désagrégation des formes solides ; 100% au test d'uniformité de volume pour les solutions. 89,65% des formes semi-solides avaient un pH conforme à la norme. L'identification par CCM a permis de mettre en évidence la présence du paracétamol et de l'aspirine dans 7,5% des échantillons collectés, le diclofénac dans 5% et l'ibuprofène dans 2,5% des échantillons.

Conclusion Ce travail nous a permis de mettre en évidence le problème de la falsification des phytomédicaments réputés antidouleurs par des antalgiques et antiinflammatoires ; en perspective nous prévoyons quantifier les teneurs en principes actifs synthétiques dans nos échantillons en vue de faciliter la prise de décision par les autorités compétentes.

Mots clés : Phytomédicaments, Falsifications, Antalgiques, Antiinflammatoires, Bénin.

CARACTERISATION PHYSICOCHIMIQUE DU MIEL APISAVANA EN VUE DE SON UTILISATION COMME MATIERE PREMIERE PHARMACEUTIQUE

Hermine ZIME-DIAWARA^{1,2}, Fidèle BADO¹, Charles B. SOMBIE^{1,4}, Josias B. G. YAMEOGO^{1,5}, Rasmané SEMDE¹

1- Laboratoire de Développement du Médicament (LADME)/EDSS/Université Joseph KI- ZERBO

2- Centre hospitalier Universitaire Yalgado Ouédrogo – Burkina Faso

3- Centre hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle – Burkina Faso

4- Centre hospitalier régional de Ziniaré – Burkina Faso

5- Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) – Burkina Faso

E-mail de l'auteur correspondant : zimegani@yahoo.fr

Introduction : Le miel fait partie des produits de la ruche. Il en existe plusieurs types en fonction de la substance butinée par l'abeille pour l'obtenir. En vue de déterminer les caractéristiques physico-chimiques du miel pour son usage pharmaceutique, une étude a été menée sur du miel produit au Burkina Faso.

Méthodologie : Des échantillons de miels "APISAVANA" ont été collectés puis analysés. Les paramètres analysés étaient l'indice de réfraction, la conductivité électrique, la teneur en eau, la teneur en 5-Hydroxyméthylfurfural, la teneur en chlorures et la teneur en sulfates. Ces paramètres physico-chimiques ont été déterminées selon les méthodes décrites par la pharmacopée européenne.

Résultats : L'analyse des paramètres physico-chimiques étudiés montre que, l'indice de réfraction est $1,49 \pm 00$, la teneur en eau est de $16,89 \pm 0,47$ (%), la conductivité électrique est de $970,18 \pm 125$ ($\mu\text{S}/\text{Cm}$), une teneur en 5-Hydroxyméthylfurfural de $14,48 \pm$ (mg/Kg), une teneur limite en chlorures de 350 ppm maximum et une teneur limite en sulfates de 250 ppm maximum.

Conclusion : Les caractéristiques physicochimiques retrouvés pour le miel APISAVANNA du Burkina Faso sont des indicateurs de bonne qualité organoleptique et de stabilité permettant d'envisager une utilisation pharmaceutique conformément aux recommandations des pharmacopées de référence.

Mots clés : Miel, caractéristiques physicochimiques, matière première pharmaceutique, production industrielle

EFFICACITE DU PROJET DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES ENFANTS DE 6 A 59 MOIS DANS LA COMMUNE DE LALO AU BENIN

Sossa Pamela¹, Sossou Ericie¹, Sopoh Ghislain¹

¹ Institut Régional de Santé publique d'Ouidah, Université d'Abomey Calavi, Bénin

Introduction : L'alimentation des enfants de 6 à 59 mois influence leur état nutritionnel et leur développement. Le Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) a été mis en place pour améliorer l'état nutritionnel et le développement des enfants dans la commune de Lalo. L'étude évalue l'efficacité du PNDPE sur les habitudes alimentaires des enfants de 6 à 59 mois.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale évaluative, quasi-expérimentale, de type ici-ailleurs, menée dans les communes de Lalo (zone d'action) et Toviklin (zone témoin). Un total de 1142 enfants (571 par commune) ont été sélectionnés par échantillonnage par grappes. Les données socioéconomiques et alimentaires ont été collectées à l'aide de questionnaires administrés aux mères. Le PNDPE était jugé efficace si la proportion d'enfants ayant de bonnes habitudes alimentaires dans le groupe d'action était significativement supérieure à celle du groupe témoin. La bonne habitude alimentaire ferait référence à l'alimentation minimale et au score de consommation alimentaire acceptables. Le test de Chi deux a été utilisé pour comparer les proportions.

Résultats : Parmi les enfants enquêtés, 53,15 % étaient de sexe masculin, avec une médiane d'âge de 26 mois et une prédominance dans la tranche [12-24[mois. La majorité des mères avaient entre 20 et 30 ans, et presque toutes étaient en union libre. Tous les enfants vivaient dans des ménages à faible niveau socioéconomique. Parmi les enfants, 43,58% du groupe action ont une alimentation minimale acceptable contre 25,42% du groupe témoin ($p < 0,01$) et 45,04% du groupe d'action avaient un score de consommation alimentaire acceptable contre 46,01% dans le groupe témoin ($p = 0,03$). La proportion d'enfants du groupe d'action ayant de bonnes habitudes alimentaires (39,23%) était supérieure à celle du groupe témoin (30,12%) ($p = 0,01$).

Conclusion : Le PNDPE a significativement amélioré les habitudes alimentaires des enfants de Lalo. Le projet mérite d'être mis à l'échelle dans toutes les communes où les habitudes alimentaires des enfants de 6 à 23 mois sont sous optimales.

FRÉQUENCE ET FACTEURS ASSOCIÉS A LA MALNUTRITION CHEZ LES ENFANTS DE 6 A 59 MOIS DANS LES CENTRES DE SANTÉ DE PARAKOU EN 2024

Kpanidja MG, Agbeille Mohamed F, Kougbo KP, Noudamadjo A, Adédémy JD, Agossou J.

Département Mère-Enfant Faculté de Médecine, Université de Parakou (Bénin)

Auteur correspondant : KPANIDJA Mèdétinmè Gérard

Adresse : 03BP369 Parakou ; Tel 00229 96967994/94543195 ; Email : m.kpanidja@yahoo.c.

Introduction : la malnutrition constitue un handicap pour le développement des enfants. L'objectif de ce travail était de déterminer la fréquence et les facteurs associés à la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 dans les centres de santé de Parakou en 2024.

Patients et méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive à visée analytique avec une collecte prospective des données. Elle s'est déroulée du 1er juin au 31 juillet 2024 dans les centres de santé périphériques de Parakou.

Résultats : Au total 462 enfants avaient été enregistrés. La sex ratio était de 1,08. L'âge moyen des enfants était de 11,24 mois $\pm$ 8,36 mois. La tranche d'âge la plus représentée était celle de 6 mois à 12 mois (83,76%). La fréquence de la malnutrition dans cette étude était de 46,97%. Les facteurs significativement associés à la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois dans les centres de santé de Parakou en 2024, étaient le sexe ($p=0,0220$), l'âge ($p=0,0016$), le rang de naissance ($p=0,0239$) de l'enfant, l'âge de la mère ($p=0,0237$), le niveau de revenu mensuel du ménage ($p=0,0406$), la religion ($p=0,0338$).

Conclusion : la bonne nutrition des enfants pourrait améliorer leur état de santé.

Mots clés: malnutrition, fréquence, facteurs, Parakou, Bénin

PREVALENCE DE L'HYPERGLYCEMIE CHEZ LES TRAVAILLEURS DE NUIT D'UN CENTRE HOSPITALIER DE ZONE AU BENIN

MIKPONHOUE OLOU Rose^{1,2}, GODONOU Rosette³, ADJOBIMEY VISSOH Mênonli^{1,4}, HOUNTOHOTEGBE Esdras⁴, HINSON Antoine Vikkey¹, AYELO Paul¹

1-Unité de recherche et d'enseignement en santé au travail et environnement de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou

2- Centre Hospitalier Universitaire de Zone de Suru-Lere

3- Centre Hospitalier Universitaire d'Abomey-Calavi

4- Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phtisiologie de Cotonou

Auteur correspondant : MIKPONHOUE Rose, nayetoon@yahoo.fr

Introduction : Les populations soumises à des perturbations de leur rythme circadien, comme les travailleurs de nuit sont à risque d'hyperglycémie et de développer des troubles métaboliques, y compris l'hyperglycémie et le diabète de type 2. Cette étude avait pour objectif de déterminer la prévalence de l'hyperglycémie chez les travailleurs de nuit d'un centre hospitalier de zone à Calavi au Bénin.

Méthodes d'étude : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive qui s'est déroulée sur une période d'un mois. Elle a concerné tous les participants travaillant de nuit depuis au moins un an au moment de l'étude et consentant à l'exclusion des travailleurs ayant un diagnostic préexistant de diabète de type 1 ou 2, des femmes enceintes et ceux qui avaient traitement corticostéroïde ou autres médicaments pouvant affecter les niveaux de glucose. L'hyperglycémie a été définie par une glycémie capillaire instantanée > 2 mg/dl. Les données ont été analysées avec le logiciel R 4.0.4.

Résultats : Au total 148 travailleurs ont été inclus. Ils étaient hommes et femmes soit une sex-ratio de 0,42. La tranche d'âge la plus représentée est était celle de 26-35 ans avec une proportion de 54,73%. L'ancienneté dans le travail de nuit de $3,64\text{ans} \pm 1,40\text{ans}$ avec les extrêmes de 1 an et de 5ans. Les médecins, infirmiers et aide soignants représentaient respectivement 11,45% ; 39,69% et 33,59% de l'échantillon. La prévalence de l'hyperglycémie chez les travailleurs de nuit dans la population étudiée était de 37,16% ; IC_{95%} : [29,47 - 45,52]. Elle était plus élevée chez ceux qui effectuaient ...nombre de gardes par semaine que les autres.

Conclusion La prévalence de l'hyperglycémie est élevée chez les travailleurs de nuit dans cette étude, souligne un risque important pour cette population. Il est essentiel de développer des stratégies de prévention et de gestion adaptées pour réduire les risques de complications métaboliques et améliorer la qualité de vie des travailleurs de nuit.

Mots clés : hyperglycémie, travail de nuit, hôpital, Bénin

Introduction : Le mauvais contrôle tensionnel est un facteur de complications cardiovasculaires chez le sujet hypertendu. Cette étude est initiée pour évaluer l'importance de l'hypertension artérielle non contrôlée masquée (HTA-NCM) dans le service de cardiologie du CNHU HKM (CUC- CNHU) afin d'améliorer la prise en charge de nos patients.

Méthodes d'étude : L'étude était descriptive et analytique avec collecte prospective des données menées d'Avril 2022 à Septembre 2022. Les patients suivis pour HTA à la CUC- CNHU avec des chiffres tensionnels inférieurs à 140/90mmHg au cabinet et ayant réalisé la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) étaient recrutés. La fréquence de l'HTA-NCM ainsi que les facteurs associés ont été étudiés grâce au logiciel IBM SPSS version 25 avec un seuil de significativité de $p < 5\%$.

Résultats : Des 396 patients contrôlés au cabinet, 75 ont réalisé la MAPA. L'âge moyen était de $58,1 \pm 13,2$ ans et la sex-ratio de 0,6. L'ancienneté de l'HTA était d'au moins 5ans chez 53,3% des patients. La dyslipidémie (50,7%) et l'obésité abdominale (62,7%) étaient les principaux facteurs de risque cardiovasculaire observés. Une suspicion de Syndrome des Apnées-Hypopnée Obstructives du Sommeil (SAHOS) était retrouvée chez 12 patients (16%). La fréquence hospitalière de HTA-NCM était de 42,7%. Les facteurs associés à l'HTA-NCM étaient le SAHOS (OR=10,4 ; $p=0,042$), la dyslipidémie (OR=4,9 ; $p=0,005$) et l'observance thérapeutique (OR=0,29 ; $p=0,044$). Ces facteurs permettent d'expliquer 23,5% des cas d'HTA-NCM.

Conclusion : L'HTA-NCM est fréquente en cardiologie au CNHU HKM. La dyslipidémie, la probabilité élevée de SAHOS, et le non-respect des mesures hygiéno-diététiques en sont les facteurs associés.

PREVALENCE ET FACTEURS DE RISQUE DU DEFICIT EN VITAMINE D CHEZ LES NOURRISSONS DANS DEUX COMMUNES AU SUD DU BENIN EN 2023

Tohodjèdé Y¹, Padonou C², Alihonou F¹, Djessoudé J², Yakoubou A³, Sagbo GG²

¹ Clinique Universitaire de Pédiatrie et Génétique Médicale du Centre National Hospitalier Universitaire – Hubert Koutougou MAGA (CNHU-HKM)

² Service de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémè-Plateau (CHUD-OP)

³ Service de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant-Lagune (CHU-MEL) de Cotonou.

Auteur correspondant : TOHODJEDE Yévèdo, +22997015642, yevredo05@yahoo.fr

Introduction : Le déficit en vitamine D est un problème mondial de santé publique. L'objectif de ce travail était de déterminer la prévalence et les facteurs de risque du déficit en vitamine D dans les communes d'Adjarra et de Porto-Novo au Bénin.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique qui a été conduite du 04 mai au 13 juin 2023. Les nourrissons âgés d'un à 18 mois, sélectionnés selon un sondage aléatoire à deux degrés ont été inclus. Les variables étudiées étaient le taux sanguin de la vitamine D, les caractéristiques sociodémographiques, cliniques et l'exposition au soleil. L'analyse des données a été faite avec le logiciel R 3.6.1. Le protocole de l'étude avait reçu un avis éthique favorable du Comité d'Ethique de la Recherche de l'ISBA (Avis n°163 du 07 avril 2023).

Résultats : La prévalence du déficit en vitamine D était de 14,5% avec une carence plus importante à Porto-Novo qu'à Adjarra ($p < 0,001$). L'âge moyen était de $9,2 \pm 4,5$ mois et un sex ratio à 1,3. Un âge compris entre 1 et 3 mois ($p = 0,049$) et une exposition au soleil inférieure à 30 min par jour entre 10 et 16 heures ($p < 0,001$) étaient associés au déficit en vitamine D. En analyse multivariée, seule une durée d'exposition au soleil inférieure à 30 min par jour était un facteur associé au déficit en vitamine D (OR à 4.56 avec IC à (2,05-10,1)).

Conclusion : Le déficit en vitamine était fréquent chez les nourrissons de un à 18 mois vivant à Porto-Novo et Adjarra et son principal facteur associé était une exposition faible au soleil.

Mots clés : Déficit en vitamine D, nourrisson, prévalence, exposition au soleil.

UN DANGEREUX CORPS ETRANGER TRACHEAL MIGRANT A DANGEROUS MIGRATING TRACHEAL FOREIGN BODY

*Lawson Afouda S., Hounlelou VE., Medji S., do Santos Zounon A., Guézo D., Adjibabi W.,
Clinique universitaire d'ORL-CCF, CNHU-HKM. Cotonou*

Introduction

Les corps étrangers des voies aériennes constituent une urgence médico-chirurgicale fréquente. Nous rapportons le cas d'un patient porteur d'une canule de trachéotomie sur une malformation laryngée. L'objectif de cette étude a été de partager l'intérêt de l'imagerie médicale et de l'endoscopie dans la prise en charge du patient.

Observation

Patient suivi à la clinique universitaire d'ORL-CCF du CNHU-KKM pour une palmure laryngée depuis Novembre 2021 à l'âge de 07 mois. Dans ses antécédents, il existe une notion de grande prématurité, d'hypotrophie et de réanimation à la naissance. Pour la prise en charge de la malformation laryngée, il a bénéficié d'une trachéotomie première. Elle a été suivie de l'exérèse de la palmure par laser, puis d'une ouverture de synéchies séquellaires du 1^{er} geste associé au calibrage du larynx par du silastic. L'évolution a été marquée par l'ablation accidentelle du silastic après rupture du fil de rappel à la peau. Le patient perdu de vue pendant plus d'un an nous a été adressé. À l'examen, il était porteur d'une canule de trachéotomie, il présentait une dyspnée laryngée stade 2 selon la classification de Chevalier Jackson et Pineau. La radiographie cervico-thoracique a objectivé la portion distale de l'ancienne canule métallique à hauteur de la carène et en direction de la bronche souche droite. L'extraction a été faite sous endoscopie à travers l'orifice de trachéotomie avec mise en place d'une nouvelle canule.

Conclusion

Difficulté de la liberté des voies aériennes chez un enfant présentant une malformation laryngée. Intérêt de l'endoscopie diagnostique et thérapeutique et nécessité d'un suivi régulier du sujet porteur de canule.

Mots clés : Corps étrangers- Voie aérienne- Canule de trachéotomie- Imagerie- Endoscopie

CAS D'UN CORPS ETRANGER NASAL PERFORANT CASE OF A PERFORATING NASAL FOREIGN BODY

*Lawson Afouda S., Hounlelou VE., Medji S., do Santos Zounon A., Guézo D., Adjibabi W.,
Clinique universitaire d'ORL-CCF, CNHU-HKM. Cotonou*

Introduction Les corps étrangers des fosses nasales sont fréquents chez les enfants. Ils sont graves par les lésions qu'ils occasionnent. L'objectif de cette étude a été de rapporter les complications liées à la présence d'une pile bouton dans une fosse nasale et sa prise en charge.

Observation Patiente de 04 ans sans antécédent, admise pour un corps étranger de la fosse nasale droite. Le début remonterait à deux semaines avant admission par une inhalation de corps étranger à type de pile bouton de calculatrice. Deux tentatives d'extraction infructueuses ont été réalisées dans un hôpital de la place. L'interrogatoire a permis de retrouver une épistaxis unilatérale droite, des rhinorrhées, une obstruction nasale bilatérale à bascule. À l'examen, la fosse nasale droite était sale avec présence de sang noirâtre. Après aspiration, le corps étranger n'a pas été vu. La radiographie standard face et profil du crâne faite a permis d'objectiver un corps étranger métallique sphérique à double contours situé en arrière du cornet inférieur droit et contre le plancher nasal droit. Elle a bénéficié d'une extraction du corps étranger sous anesthésie générale. En per opératoire, on découvre une absence du cornet inférieur droit après la nécrose de la muqueuse, une pile enclavée en position transversale entre la tête du cornet moyen droit et la cloison nasale. Après extraction, perforation large à la jonction cartilage septal et le vomer en arrière.

Conclusion Surveillance des enfants à l'âge de la préhension. En cas de corps étranger des fosses nasales surtout érosif, la prise en charge doit être précoce et réalisée par un personnel qualifié. Des conditions optimales d'extraction sont nécessaires.

Mots clés : Corps étranger- Fosse nasale- Pile bouton- Complications

ORTHODONTIE : A QUOI ÇA SERT ?

DOHOU G. A. M., DAHOUE T. R., BANCOLE POGNON S., do SANTOS Z. A., VODOUHE U., LAWSON AFOUDA S., AVAKOUDJO F., CHABI W., ADJIBABI W.
UFR- ORL- CCF/ FSS/ UAC

Introduction Les corps étrangers des fosses nasales sont fréquents chez les enfants. Ils sont graves par les lésions qu'ils occasionnent. L'objectif de cette étude a été de rapporter les complications liées à la présence d'une pile bouton dans une fosse nasale et sa prise en charge.

Observation Patiente de 04 ans sans antécédent, admise pour un corps étranger de la fosse nasale droite. Le début remonterait à deux semaines avant admission par une inhalation de corps étranger à type de pile bouton de calculatrice. Deux tentatives d'extraction infructueuses ont été réalisées dans un hôpital de la place. L'interrogatoire a permis de retrouver une épistaxis unilatérale droite, des rhinorrhées, une obstruction nasale bilatérale à bascule. À l'examen, la fosse nasale droite était sale avec présence de sang noirâtre. Après aspiration, le corps étranger n'a pas été vu. La radiographie standard face et profil du crâne faite a permis d'objectiver un corps étranger métallique sphérique à double contours situé en arrière du cornet inférieur droit et contre le plancher nasal droit. Elle a bénéficié d'une extraction du corps étranger sous anesthésie générale. En per opératoire, on découvre une absence du cornet inférieur droit après la nécrose de la muqueuse, une pile enclavée en position transversale entre la tête du cornet moyen droit et la cloison nasale. Après extraction, perforation large à la jonction cartilage septal et le vomer en arrière.

Conclusion Surveillance des enfants à l'âge de la préhension. En cas de corps étranger des fosses nasales surtout érosif, la prise en charge doit être précoce et réalisée par un personnel qualifié. Des conditions optimales d'extraction sont nécessaires.

Mots clés : Corps étranger- Fosse nasale- Pile bouton- Complications

PRODUCTION DES RESSOURCES HUMAINES EN MEDECINE NUCLEAIRE AU BÉNIN : ETAT DES LIEUX EN 2024 ?

HOUNDETOUNGAN GD¹, FACHINAN OH², AGBOTON FBP¹, ABOGBO G¹, OBEY C¹, AMOUSSOU-GUENOU KM¹

¹ Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

² Université de Parakou (Bénin)

Auteur correspondant : HOUNDETOUNGAN Gilles David ; email : fododavid@yahoo.fr

Introduction

La médecine nucléaire est une spécialité médicale utilisant des sources radioactives non scellées à des fins diagnostiques et/ou thérapeutiques. Le but de cette communication est de faire l'état des lieux des ressources humaines en médecine nucléaire disponibles au Bénin en 2024.

Méthodologie

Il s'agit d'une étude transversale descriptive menée en juillet 2024. Les données, en rapport avec les ressources humaines, ont été collectées à l'unité d'enseignement et de recherche de biophysique, médecine nucléaire, aux services de médecine nucléaire et au ministère de la Santé.

Résultats

Sur toute l'étendue du territoire national, il n'existe que deux services de médecine nucléaire avec des activités limitées au radioimmunodosage. Cependant, le pays dispose en 2024 de 17 agents qualifiés en médecine nucléaire, dont 3 médecins nucléaires, 3 pharmaciens radiopharmaciens, 6 technologues, 2 physiciens médicaux et 3 manipulateurs de radioimmunodosage. En dehors des manipulateurs de radioimmunodosage, qui ont effectué leurs stages au Bénin, les 15 autres agents ont suivi leur formation à l'étranger : 2 au Ghana, 1 au Sénégal, 5 au Maroc, 5 en Algérie et 3 en France. Quatorze agents, soit 78 %, ont bénéficié de l'appui financier de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique.

Sept sont en instance d'être recrutés, 4 sont sous-utilisés en raison de l'inexistence de la scintigraphie, et 2 sont utilisés dans d'autres spécialités.

Conclusion

Le Bénin dispose de ressources humaines qualifiées en médecine nucléaire malgré la faible disponibilité des services de cette spécialité. Le démarrage des activités dans le service de médecine nucléaire du centre hospitalier international de Calavi est vivement attendu pour leur utilisation efficiente.

Mots-clés : médecine nucléaire, production, ressources humaines, Bénin.

ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES ETUDIANTS POUR AMELIORER L'ENSEIGNEMENT DE BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE EN 3EME ANNEES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE A LA FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE DE COTONOU ?

Orékan FAJ ^{1,2}, Sodjinou MM ^{1,2}, Wakpo ARA ², Affolabi D ^{1,2}.

¹ Unité de Bactériologie-Virologie, FSS, UAC.

² Laboratoire de Bactériologie-virologie du CNHU-HKM de Cotonou.

Introduction. L'évaluation du cours à l'enseignement supérieur par les étudiants est l'un des moyens d'amélioration de la qualité des cours administrés. C'est dans cette optique que l'unité de bactériologie-virologie réalise depuis plusieurs années, des évaluations périodiques de l'enseignement par les étudiants. Ces évaluations étaient libres mais à partir de l'année académique 2023-2024, elle a été faite à l'aide d'un questionnaire mixte fait de questions ouvertes et fermées administré aux étudiants.

Objectif. Recueillir les avis des étudiants sur l'enseignement de bactériologie-virologie en vue de son amélioration.

Méthodologie. Une fiche d'enquête a été élaborée puis auto-administrée par les étudiants. Elle comportait des questions fermées sur les items suivants : ponctualité de l'enseignant au cours, la voix de l'enseignant, les explications données, l'ambiance générale pendant le cours, l'impression globale sur le cours. Les questions ouvertes concernaient les commentaires généraux sur le cours. L'administration de la fiche a été faite à l'avant-dernier cours de l'année puis la restitution de l'évaluation au cours suivant.

Résultats. Au total, 65 étudiants sur 137 étaient présents lors de l'enquête et tous y ont participé. Sur la ponctualité de l'enseignant, 98% avaient donné une note de très bien. Concernant la voix de l'enseignant, 100% avaient noté une voix très audible. Le débit de l'enseignement et les explications données étaient satisfaisants pour 100% des étudiants. L'ambiance générale pendant le cours était satisfaisante pour 100% des étudiants et tous avaient une bonne impression globale du cours. A propos des cours en ligne, 12% n'y étaient pas favorables pour diverses raisons. Les recommandations portaient sur le démarrage des travaux pratiques un peu plus tôt et l'illustration du cours avec un peu plus d'images.

Conclusion. La plupart des étudiants étaient satisfaits du cours de bactériologie-virologie. Les points de recommandations seront utilisés pour améliorer le cours en attendant d'utiliser le nouveau formulaire d'évaluation de l'enseignement qui sera proposé par le décanat suivant le modèle du CAMES.

Mot clés. Enseignement, bactériologie-virologie, enquête de satisfaction.

PREVALENCE DU BURNOUT CHEZ LES SOIGNANTS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU

MIKPONHOUE OLOU Rose^{1,2}, GNANVI Sandrine³, DEGBEY Cyriaque³, ADJOBIMEY VISSOH Mênonli^{1,4}, HINSON Antoine Vikkey¹, AYELO Paul¹

1-Unité de recherche et d'enseignement en santé au travail et environnement de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou

2- Centre Hospitalier Universitaire de Zone de Suru-Lere

3- Service de l'hygiène hospitalière du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou

4- Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phtisiologie de Cotonou

Auteur correspondant : MIKPONHOUE Rose, nayetoon@yahoo.fr

Introduction : Les professionnels de santé travaillant dans les services hospitaliers sont à risque de burnout ou syndrome d'épuisement professionnel.

Objectif : Etudier la prévalence et les facteurs associés au burnout chez les professionnels de santé dans les cliniques universitaires de soins d'urgence au CNHU-HKM à Cotonou en 2024

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale, descriptive qui s'est déroulée du 15 Février 2024 au 31 Mai 2024. Elle a inclus tous les soignants des cliniques universitaires d'accueil des urgences, d'anesthésie-réanimation, pédiatrie, gynécologie-obstétrique et cardiologie, présents au moment de l'enquête et consentants. La prévalence et la gravité du burnout étaient déterminées à partir du score MBI (Maslach Burnout Inventory), une échelle explorant l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et l'accomplissement personnel. Les données ont été analysées avec le logiciel R 4.2.2

Résultats : Au total, 150 soignants ont été inclus dans l'étude. Ils étaient 70 hommes et 78 femmes soit une sex ratio de L'âge moyen était de 41ans avec une ancienneté de plus de 10ans dans 2/3 des cas. La prévalence du burnout était de 74 % présentait un burnout léger, 25 % un burnout modéré et 1% un burnout sévère. Les principales dimensions atteintes étaient ; l'épuisement émotionnel élevée (EE = 68%), la dépersonnalisation faible (DP=54.67%) et l'accomplissement personnel faible (AP= 42.67%)

Conclusion : La prévalence du burnout chez les professionnels de santé dans les services de soins d'urgence au CNHU-HKM était élevée. Des mesures de prévention sont indispensables pour l'efficacité et le maintien dans l'emploi de ces derniers

Mots clés : Burnout, prévalence, soignants, CNHU-HKM.

PROFIL PSYCHOPATHOLOGIQUE DES SUJETS REÇUS EN EXPERTISE PSYCHIATRIQUE PENALE AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIQUE DE COTONOU DE 2018 A 2023

KLIKPO E¹, NGOGANG NGUEMOU M², AZA GNANDJI GG¹, GANSOU GM²

1- Clinique universitaire de santé mentale, CNHU-HKM, Cotonou, Bénin

2- Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : Elvyre KLIKPO Email : eklikpo@gmail.com

L'expertise psychiatrique pénale est un processus au cours duquel un psychiatre est sollicité par la justice ou un représentant de l'état pour évaluer l'état mental d'une personne impliquée dans une affaire pénale. Ce travail avait pour objectif d'étudier le profil psychopathologique des sujets évalués en expertise psychiatrique pénale au Centre National Hospitalier Universitaire de Psychiatrie dans la ville de Cotonou. Il s'est agi d'une étude descriptive avec recueil rétrospectif des données s'étendant sur une période de 5 ans ; de Mai 2018 à Mai 2023. Les sujets de 18 ans et plus, reçus en expertise psychiatrique pénale dans ledit centre ont été systématiquement recrutés. Parmi les 79 rapports d'expertises dépouillés, 66 sujets étaient des hommes. L'âge moyen des sujets était de 36,48 ans $\pm$ 16,6 avec des extrêmes de 18 et 81ans. La demande d'expertise provenait principalement des commissariats par réquisition pour des sujets en garde à vue (65,82%). Les violences physiques, la suspicion d'appartenance à une organisation terroriste, le trouble à l'ordre public et l'homicide étaient les infractions les plus commises. La schizophrénie (27,84%) et le trouble psychotique induit par les substances psychoactives (15,19%) étaient les pathologies les plus représentées. L'abolition du discernement a été rapportée dans 11,39% des cas. L'abolition du discernement était principalement retenue chez des sujets souffrant de schizophrénie, trouble dépressif caractérisé avec caractéristiques psychotiques et de psychose épileptique. Une prise en charge a été décidée chez plus de la moitié des sujets évalués. Pour trois sujets sur quatre hospitalisés, l'évolution a été favorable. L'expertise psychiatrique pénale permet de déterminer si une personne était, au moment des faits, en mesure de comprendre la nature et la portée de ses actes, et si elle était capable de contrôler ses impulsions.

Mots clés : expertise psychiatrique pénale, profil psychopathologique, CNHUP-C

ESTIMATION DE L'ÂGE OSSEUX EN IRM DU FOOTBALLEUR DE MOINS DE 17 ANS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU

AYI MEGNANGLO CA¹, ADJADOHOUN SBMG¹, WHENU P¹, SANSOUAMOU ET¹, AGAI JB², YEKPE AHOUANSON P¹.

¹Clinique Universitaire d'Imagerie médicale, Centre National Hospitalier et Universitaire HKM de Cotonou (Bénin)

²Service de Radiologie et Imagerie du Centre Hospitalier Départemental Borgou-Alibori, Parakou (Bénin)

Auteur correspondant : Ayi Megnanglo Codjo Austher, Assistant FSS Cotonou

Email : macod55@yahoo.fr Tél : 00229 95454430

Introduction

La fraude sur l'âge dans le sport de haut niveau est un sujet d'actualité en particulier chez les footballeurs de moins de 17 ans et surtout dans les pays où l'enregistrement des naissances n'est pas systématique. Un recours à l'IRM est souvent sollicité pour la détection de l'âge osseux des footballeurs.

L'objectif de cette étude est de décrire la place de l'IRM dans la détermination de l'âge osseux.

Matériel et méthode : étude rétrospective et descriptive sur une période de 4 mois de Avril à Juillet 2024. Etaient inclus tout joueur ayant bénéficié d'une IRM du poignet gauche pour détection de l'âge osseux. Le protocole avait consisté à la réalisation d'une séquence T1 SE Coronal du poignet gauche

Résultats : ont été examinés 54 joueurs de sexe masculin et de nationalité béninoise. Ils n'avaient aucune pathologie connue. Selon leurs documents administratifs, ils étaient tous âgés d'au plus 17 ans. Le plus jeune avait 12 ans 2 mois et le plus âgé avait 16 ans 4 mois. La répartition des joueurs selon le stade de fusion de la physe radiale était comme suit : I (11.11%), II (20.37%), III (22.22%), IV (18.51%), V (22.22%) et VI (5.55%). Ainsi, 53.7% des joueurs avaient un âge < 17 ans. La concordance entre l'âge civil déclaré et l'âge détecté en IRM était de 29.63%.

Conclusion

L'IRM a été contributive car ayant permis de faire l'estimation de l'âge osseux chez les joueurs et ainsi de limiter les fraudes dans ce domaine.

Mots clés : IRM, âge osseux, poignet, footballeur, Cotonou.

SYNDROME CATATONIQUE CHEZ LES ADOLESCENTS : À PROPOS D'UN CAS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA EN 2024

DANIELLE M, LEGBA AA, ZEHE G, MBENDE MA, ANAGONOU L

Auteur correspondant : DANIELLE MBWANG N.A. Tel : +229 57576631 E-mail : ngwakadanielle@gmail.com

La catatonie est un syndrome trans-nosographique qui regroupe de façon diverse des symptômes moteurs, comportementaux, affectifs et neurovégétatifs ; elle est associée à une cause psychiatrique dans 75-80% des cas. Chez l'enfant et l'adolescent, parmi les étiologies psychiatriques, la schizophrénie à début précoce est plus fréquente, notamment chez le garçon.

Nous rapportons l'observation clinique d'un adolescent de 19 ans, orienté en pédopsychiatrie par un neurologue pour mutisme total. L'entretien pédopsychiatrique retrouvait à l'anamnèse, un début de la symptomatologie remontant à 10 mois environ avant la consultation par suite d'un échec académique, le tout premier échec du parcours scolaire du patient. Les symptômes se sont installés progressivement marqués initialement par des ruminations anxieuses, un retrait social associé à une clinophilie. Il s'en était suivi des troubles du comportement à type de soliloquie, incurie corporelle, mutisme. Une consultation neurologique avait été faite et le patient orienté en pédopsychiatrie. L'entretien et l'examen clinique réalisés ont permis de noter un refus de la main tendue, un mutisme, une perte de l'initiative motrice et un maintien de la posture. Le diagnostic d'une catatonie associée à une schizophrénie à début précoce a été évoqué. Le patient a bénéficié d'un traitement médicamenteux et psychothérapeutique, avec une rémission partielle clinique en 05 mois de suivi.

Cette situation clinique met en lumière d'une part le lien entre syndrome catatonique et pathologies psychiatriques, et d'autre part l'étiologie la plus représentée de ce syndrome chez le jeune garçon qu'est la schizophrénie à début précoce.

Mots-clés : Catatonie, adolescents, schizophrénie, Cotonou.

LA PRISE EN CHARGE DE L'INFRACLUSION ANTERIEURE EN ORTHOPEDIE DENTO FACIALE A PROPOS DE DEUX CAS COLLIGES AU CENTRE DE CONSULTATION ET DE TRAITEMENT DENTAIRE DE RABAT

DAHOUE T. R., DOHOU G. A. M., BANCOLE POGNON S., do SANTOS Z. A., LAWSON AFOUDA S., AVAKOUDJO F., VODOUHE U., ADJIBABI W.

UFR- ORL- CCF/ FSS/ UAC

Introduction : L'infraclusion antérieure encore appelée une béance antérieure est une anomalie du sens vertical caractérisée par une absence ou une insuffisance de recouvrement des dents mandibulaires par celles maxillaires. Ses origines peuvent être squelettiques ou dento alvéolaires. Leur prise en charge peut se faire par une ingression des molaires ou par une égression du secteur antérieur ou par un protocole ortho chirurgical. L'objet de notre travail est de rapporter deux cas de béances pris en charge au CCTD de Rabat.

Patients et Méthodes : Le premier cas est une jeune adulte âgée de 20 ans reçue en consultation pour un motif esthétique. L'examen clinique, l'examen fonctionnel et l'analyse céphalométrique ont permis de conclure aux diagnostics squelettique de classe III hypodivergent, dento squelettique biproalvéolie, dento dentaire dysharmonie dento maxillaire de +12,8 mm selon Tweed classe I molaire et canine, esthétique prochéilie inférieure, une incompétence labiale supérieure et une déglutition atypique avec une interposition linguale. Un traitement orthodontique sans extraction a été institué. Le deuxième cas est une adulte de 20 ans de classe trois squelettique avec un décalage important des bases osseuses, un profil concave et un articulé inversé antérieur. Un traitement orthochirurgical a été institué à partir du bilan diagnostique.

Résultat : Le premier cas présente une occlusion de classe I molaire et canine, un surplomb et un recouvrement corrects avec un sourire plaisant. Le deuxième cas a subi une véritable métamorphose avec une occlusion classe I molaire et canine, un surplomb et un recouvrement corrects.

Conclusion : La prise en charge des infraclusions antérieures est un véritable challenge pour l'orthodontiste qui doit hypercorriger le trouble et rééduquer les différentes fonctions orofaciales pour assurer la pérennité du résultat.

Mots clés : Béance antérieure, classe III squelettique, chirurgie ortho gnathique, dysharmonie dento maxillaire

La santé des adolescents et des jeunes est caractérisée par une insuffisance d'offre de services de santé de la reproduction, avec pour conséquence des rapports sexuels précoces non protégés, des grossesses précoces et non désirées, des avortements provoqués clandestins, un nombre élevé de cas d'infections à VIH et de violences diverses. Pour y remédier des programmes et projets sont mises en œuvre dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Cependant des limites relatives aux normes sociales et aux contextes institutionnels de mise en œuvre, constituent des défis majeurs face auxquelles les professionnels de premières lignes développent des stratégies de contournement. La présente étude, à l'aide d'une méthode ethnographique fine au sein des communautés, des services sociaux, des formations sanitaires, des collèges d'enseignement secondaires en milieu rural et urbain au Bénin, a identifié des micros réformateurs et les solutions qu'ils mettent en œuvre pour améliorer au quotidien les services de PF aux jeunes.

A l'issue de la recherche, 26 solutions endogènes ou pistes de solutions ont été répertoriées, mises en œuvre par des agents de santé, des enseignants, des assistants sociaux, des jeunes ou des acteurs de la société civile. Elles concernent par exemple des innovations digitales, des changements d'heures de travail, l'utilisation de normes sociales pour passer des messages d'éducation à la santé, des stratégies pour garantir l'anonymat des jeunes utilisateurs de produits contraceptifs, etc.

En tirant partie des solutions endogènes adaptées aux réalités locales, le Bénin peut transformer positivement la santé reproductive des jeunes par des programmes down-top plutôt que top down qui ont montré leurs limites.

LESIONS OCULAIRES LIEES A LA DEPIGMENTATION COSMETIQUE VOLONTAIRE AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA EN 2023

TONOUDO G.¹, ADJIBI D.¹, ABOUKI C.², AIGBE N.¹, ALAMOU S.¹, ODOULAMI L.⁴

¹: Clinique Universitaire d'Ophtalmologie du Centre National Hospitalier Universitaire-HUBERT KOUTOUKOU MAGA (CNHU-HKM de Cotonou, Bénin).² : Service d'Ophtalmologie du Centre Hospitalier Départemental Universitaire de l'Ouémé et du Plateau (CHDU-OP de Porto-Novo, Bénin). ³ : Service d'Ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire de Zone Suru-Lere (CHUZ-SL de Cotonou, Bénin).

Auteurs correspondants : Pr ODOULAMI Lisette, Professeur Titulaire d'Ophtalmologie, Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou-Bénin. Tél : +22995404420, E-mail : lisetteodoulami@yahoo.fr

Introduction

La Dépigmentation Cosmétique Volontaire (DCV) est définie comme l'ensemble des procédés visant à obtenir un éclaircissement de la peau dite « noire » par l'utilisation à visée cosmétique de produits dont les propriétés dépigmentantes sont clairement établies. Notre objectif est d'étudier les lésions oculaires liées à la dépigmentation cosmétique volontaire au CNHU-HKM en 2023.

Matériel et méthode

Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et analytique avec collecte rétrospective et prospective des données sur une période de douze (12) mois allant du 1er Septembre 2022 au 31 Août 2023. Les registres de consultation et les dossiers médicaux de tous les patients pratiquant la DCV, ayant consulté dans le service de dermatologie ou d'ophtalmologie du CNHU-HKM ont été inclus.

Résultats

Les lésions oculaires liées à la DCV étaient présentes à 75,5%. Les principales lésions oculaires retrouvées étaient l'ochronose exogène de la paupière à 92,5%, l'ochronose conjonctivale à 47,5% et la cataracte à 42,5%. L'hydroquinone était le produit le plus utilisé soit 42,5%. Plus la durée d'utilisation du produit dépigmentant était longue, plus le risque de cataracte était élevé soit 68,8% ($p=0,006$).

Conclusion : La DCV représente un réel problème de santé publique par sa fréquence et ses complications, surtout oculaires. Des campagnes de sensibilisation sur les conséquences oculaires de la DCV sont nécessaires afin d'amener la population au changement de comportement.

Mots clés : Dépigmentation cosmétique volontaire, lésions oculaires, produit dépigmentant

SATISFACTION GLOBALE DES PARENTS SUR LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES HOSPITALISES DANS L'UNITE DE NEONATOLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2024

Bagnan Tossa L¹, Tohodjé Y¹, Ahouassou E¹, Seidou H¹

¹Clinique Universitaire de Pédiatrie et de Génétique Médicale, Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert K.Maga, Cotonou (Bénin)

Auteur correspondant : lehilabagnan@gmail.com Tél : 00 229 97 31 16 85

Introduction : La satisfaction des parents à l'égard des soins aux nouveau-nés fait partie intégrante de la réduction de la mortalité néonatale. Elle est une stratégie efficace en vue d'une amélioration de la qualité des soins. Le but de notre étude était d'étudier les facteurs associés à la satisfaction globale des nouveau-nés hospitalisés en néonatalogie du CNHU-HKM. **Méthode** : Il s'agissait d'une étude observationnelle de type transversale à visée descriptive et analytique avec collecte prospective des données sur une période de deux mois (1^{er} Mai au 30 Juin 2024). Les variables d'étude étaient les données sociodémographiques des nouveau-nés et des parents, les données cliniques des nouveau-nés et les données liées à la satisfaction. L'analyse des données a été faite selon le logiciel SPSS version 2021. **Résultats** : Au total 422 parents ont été enquêtés. La satisfaction globale des parents sur la prise en charge de leur enfant était de 82,46%. La majorité des parents enquêtés (66,35%) était des mères, avec un âge moyen de $28,59 \pm 5,05$ et un niveau d'instruction du primaire. Pour les nouveau-nés, le sex-ratio était de 1,49. Un sur trois (30,81%) était des nouveau-nés sains. Le diagnostic à l'admission était une infection néonatale probable. Les parents étaient satisfaits des différents aspects de l'accueil avec un score de satisfaction élevé de 3. Ils étaient peu satisfaits des soins néonataux avec un score de 2. La relation soignant-parent et les prestations de services étaient satisfaisants avec un score élevé de 3. Les facteurs associés : le sexe, la durée de séjour et l'état clinique à l'admission du nouveau-né, l'âge des parents, le niveau d'instruction du père, le type de parent, la disponibilité de la prise en charge avaient une influence sur la satisfaction globale des parents. **Conclusion** : Il est préférable de fournir une formation continue aux soignants notamment dans la communication soignant-parent afin d'améliorer la satisfaction des parents à l'égard des soins néonataux et une amélioration du coût des prestations. Mots-clés : satisfaction – parents – nouveau-nés – prise en charge- néonatalogie

VECU DES MERES D'ENFANTS PORTEURS DE CARDIOPATHIES CONGENITALES SUIVIS AU CNHU-HKM DE COTONOU

Bagnan Tossa L¹, Adjagba MP², Nsizoa IM¹, Seidou H¹

¹Clinique Universitaire de Pédiatrie et de Génétique Médicale, Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert K.Maga, Cotonou (Bénin)

²Unité de Soins, d'Enseignement et de Recherche en Cardiologie, Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert K.Maga, Cotonou (Bénin)

Auteur correspondant : lehilabagnan@gmail.com Tél : 00 229 97 31 16 85

Introduction : Les cardiopathies congénitales constituent un véritable problème de santé publique. Le diagnostic tardif et l'insuffisance du plateau technique chirurgical adéquat pour leur prise en charge optimale accroît le risque de mortalité infanto-juvénile. Depuis l'annonce du diagnostic anténatal jusqu'au suivi quotidien, le vécu des mères d'enfants porteurs de cardiopathie congénitale est empreint d'émotions diverses. L'objectif de cette étude était de décrire le vécu des mères d'enfants porteurs de cardiopathie congénitales suivis au CNHU/HKM de Cotonou. **Méthode d'étude :** il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et analytique qui s'est déroulée du 15 Avril au 15 Septembre 2021. Les informations ont été recueillies à partir des dossiers médicaux des enfants, et d'un entretien structuré avec les mères pour préciser la qualité de l'annonce, l'impact émotionnel et psychologique de cette annonce ainsi que le vécu lors du suivi de l'enfant. L'analyse des données a été réalisée avec le logiciel Epidata 3.1 et SPSS 25. Les facteurs associés au vécu des mères ont été identifiés par un modèle univarié. Le seuil de significativité statistique était de 5%. **Résultats :** Au total, 63 mères ont été incluses dans l'étude. L'âge médian était de 34,5 ans. Elles étaient majoritairement des commerçantes (31,7%) en très grande partie instruites : niveau secondaire 42,9%. La majorité des mères avaient un revenu financier mensuel de 70.000 francs en moyenne. L'annonce du diagnostic de cardiopathie avait été faite pour la majorité des cas par le cardiologue (40,3%) avec beaucoup de tact (66,7%). Les mères avaient très mal vécu l'annonce en majorité (55,6%). Elles avaient peur de la mort de leur enfant dans 52,2% des cas. Certaines mères n'avaient pas manifesté le désir d'un accompagnement psychologique (47,5%). Concernant le vécu après l'annonce du diagnostic, le retard dans la prise en charge chirurgicale était remarqué par 84,2% des mères. Concernant les facteurs associés au vécu des mères, la qualité de l'annonce et le mauvais vécu de la cardiopathie par la mère montraient un lien statistiquement significatif ($p=0,0016$). **Conclusion :** Un accompagnement psychologique des parents dans le suivi de ces enfants s'impose **Mots-clés :** vécu-mère-enfant-cardiopathie congénitale

ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, CLINIQUES ET EVOLUTIFS DE L'ANEMIE NEONATALE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L'OUEME PLATEAU

PADONOU BOKO C^{1,2}, SITCHEPIN MOPE N¹

(1) Centre Hospitalier Universitaire Départemental Ouémé Plateau (CHUD-OP)

(2) Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou

Auteur correspondant : PADONOU BOKO Caroline

Email : carolinepadonou@yahoo.fr; Tél : 229 97341382

Introduction : L'anémie néonatale est fréquente dans les unités de néonatalogie. L'objectif de cette étude était d'étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs de l'anémie néonatale de l'unité de néonatalogie du CHUD-OP à Porto-Novo

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale et descriptive avec collecte prospective des données menée du 1^{er} avril au 30 Juin 2023. Ont été inclus tous les nouveau-nés de zéro à 28 jours admis de l'unité au cours de l'étude et ayant bénéficié d'un hémogramme montrant une anémie (taux d'hémoglobine < 14 g/dl chez le prématuré et inférieur à 15g/dl chez le nouveau-né à terme). Les données ont été recueillies par Kobocollect et analysées à l'aide du logiciel SPSS version 26.0.

Résultats : Sur 425 nouveau-nés ayant bénéficié d'un hémogramme, 201 ont présenté une anémie : une prévalence de 47,3%. Les nouveau-nés à terme étaient les plus représentés (66,7%). La prévalence de l'anémie était de 31,5% et 15,8% respectivement chez les nouveau-nés à terme et les prématurés. Le sex-ratio garçon/fille était de 1,2 et la moyenne d'âge de $7 \pm 9,3$ jours. La tranche d'âge de 0 à 7 jours était la plus représentée (90,5%). Les principaux motifs d'hospitalisation étaient la détresse respiratoire (24,9%), la prématurité (22,4%), et l'ictère (15,4%). Les étiologies étaient dominées par les infections bactériennes (59,7%), l'ictère (36,3%), l'asphyxie périnatale (27,4%) et la prématurité (20,4%). Le taux de transfusion était de 21,4% et la létalité de 15,4%.

Conclusion : La prévalence de l'anémie néonatale est élevée au CHUDOP et ses étiologies dominées par les infections bactériennes. Leur prévention ainsi qu'un meilleur suivi de la grossesse et l'accouchement réduiraient la survenue de l'anémie chez les nouveau-nés.

Mots clés : anémie néonatale, épidémiologie, étiologies de l'anémie néonatale.

TUMEURS CEREBRALES DE L'ADULTE AU CNHU-HKM : PROFIL HISTOLOGIQUE ET DEFIS DE LA PRISE EN CHARGE

Alihonou T, Gankpe F, Lokossi F, Hode L, Agbo-Panzo M.

Clinique Universitaire de Neurochirurgie, CNHU-HKM de Cotonou

Introduction

Le parcours de soins des tumeurs cérébrales connaît une nette amélioration depuis plusieurs années avec l'essor des techniques de diagnostic. Au Bénin cependant, il reste de nombreux défis à relever. Cette étude a pour but de rapporter le profil histologique et les écueils de la prise en charge des tumeurs de l'adulte au CNHU-HKM.

Méthode

Il s'agit d'une étude descriptive et analytique à collecte rétrospective de 2014 à 2023, portant sur des patients de 18 ans et plus porteurs d'une tumeur cérébrale.

Résultats

Cent patients ont été pris en charge. Il existait une prédominance masculine (sex ratio : 1,33). L'âge moyen était de 46 ± 14 ans [18 ; 82 ans]. Le délai moyen d'évolution des symptômes était de $35,28 \pm 45$ semaines (9 mois). Cent patients ont été opérés, et 2 ont bénéficié de la radiothérapie. Le délai opératoire moyen était de $159,42 \pm 237$ jours (5 mois). Le méningiome (40 %), l'adénome hypophysaire (28 %) et le gliome (15 %) étaient les types histologiques les plus fréquents. Le taux de mortalité a été de 14% et 27% des patients ont été perdus de vue. Il existait une différence statistiquement significative entre la mortalité et la présence d'une métastase ($p=0,019$) ; ainsi que la qualité d'exérèse ($p = 0,006$).

Conclusion

L'amélioration de la qualité de la prise en charge des tumeurs cérébrales au CNHU-HKM exige une meilleure finesse diagnostique et thérapeutique (qualité de l'exérèse et traitement complémentaire)

Mots clés : tumeurs cérébrales, exérèse, chimiothérapie, radiothérapie.





LA KINESITHERAPIE A LA CROISEE DES CHEMINS

Auteurs : *HOUNGBÉDJI Mabèrou Germain^{1,2}*

Affiliations :

- ¹Ecole Supérieure de Kinésithérapie ; Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi
- ²Centre de kinésithérapie et de réadaptation Médicale Sainte-Cécile de Fidjrossè, Cotonou

L'École Supérieure de Kinésithérapie (ESK) a fêté son vingt-quatrième anniversaire de vie depuis cette rentrée universitaire 2024-2025. Elle a produit depuis ces années des cadres qui exercent à plusieurs niveaux de la pyramide Sanitaire tant nationale qu'internationale mais aussi dans l'enseignement et les laboratoires de recherche des universités béninoises et du monde. Il s'agit donc d'une École qui a atteint l'âge de la maturité mais qui se trouve face à d'énormes défis dont : la mondialisation de la profession kiné, les avancées scientifiques et les exigences de la qualité dans les soins et la recherche, l'autonomie fonctionnelle, la pérennisation des acquis et la croissance de ses activités. La présente communication se veut une réflexion sur les chances et stratégies de réussite possible pour un futur rassurant de l'ESK.

Mots clés : École supérieure de kinésithérapie ; Kinésithérapie ; Avancées scientifiques.



MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION, KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE : QUEL ENCRAGE DANS LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP ?

FATON AD, NIAMA NATTA D, AMOUZOUNKJ, ALAGNIDE HE, KPADONOU GT

Clinique Universitaire de Médecine Physique et de Réadaptation – CNHU HKM Cotonou

Auteur correspondant : Dr Alexandre Dossou FATON, dafaton@yahoo.fr

Introduction

La Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) est une spécialité médicale transversale ou interdisciplinaire située de ce fait au carrefour des spécialités médicales et chirurgicales. Elle met en jeu plusieurs spécialistes autour du même patient afin de lui rendre la meilleure autonomie possible. Cela exige l'établissement d'un projet thérapeutique pour chaque patient que l'équipe multidisciplinaire s'efforce à faire aboutir avec l'appui de la famille. Cette équipe comprend outre le médecin MPR qui en est le coordinateur, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, l'orthoprothésiste, le psychomotricien, le diététicien...etc. Notre intérêt pour les trois premiers vient du fait que la FSS forme des médecins MPR, des kinésithérapeutes et bientôt des ergothérapeutes. Dans ces conditions, on peut se demander la responsabilité de chacun de ces professionnels de la réadaptation dans la gestion du projet thérapeutique conçu pour chaque patient?

1. Clarifications conceptuelles [Gedda M. et al en 2009. Pinsault N et al en 20214]

1.1 Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)

La MPR est une spécialité médicale transversale dont l'objet est la fonction ; elle vise à réduire au strict minimum possible le handicap dû aux déficiences et incapacités.

Le médecin MPR est le spécialiste qui a pour rôle de coordonner et d'assurer la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir ou réduire au minimum inévitable, les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales et économiques des déficiences et des incapacités.

1.2. Kinésithérapie

Du grec *kinesis* et *therapeia*, la kinésithérapie est une discipline de santé, une science clinique, une spécialité paramédicale qui utilise des mouvements actifs ou passifs pour prévenir ou traiter les déficiences et les limitations d'activités.

1.3. Ergothérapie

Étymologiquement, l'ergothérapie est composée des mots grecs *ergon* et *therapeia*, qui signifie rééducation par le travail ou par l'action. C'est une spécialité paramédicale qui fonde son action sur le lien entre l'activité humaine et la santé (OMS). Elle intervient chez une personne ayant des difficultés pour accomplir ses activités de la vie quotidienne (AVQ) par la rééducation, la réadaptation, l'aménagement de domicile et la préconisation d'aides techniques.

1.4. Handicap

C'est un préjudice, un désavantage qui résulte de la déficience et de l'incapacité et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socio- culturels.

2. Historique [Pinsault N et al en 20214; H. Hernandez, 2010]

2.1. Historique de la MPR

L'histoire mondiale de la MPR se décline en trois (3) grandes périodes :

- les temps anciens avec la problématique de la place de la PH dans la société ;
- la période des deux (2) guerres mondiales avec l'émergence de la réadaptation médicale ;
- la période contemporaine avec l'organisation formelle de la MPR.

2.2. Histoire de la kinésithérapie

Le terme de kinésithérapie serait apparu pour la première fois au XIX^e siècle, sous la plume du suédois Carl Augustus Georgii. La discipline a connu plusieurs étapes en passant des pratiques empiriques à une structuration scientifique des principes de la gymnastique médicale. Les besoins engendrés par la 1^{ère} guerre mondiale amènent à créer la spécialité d'infirmier-masseur. Ensuite les professions de gymnastes médicaux et d'infirmier-masseurs vont fusionner pour donner celle de masseur-kinésithérapeute en 1946.

2.3. Histoire de l'Ergothérapie

Depuis l'Antiquité, l'activité a montré ses bienfaits dans la vie humaine et particulièrement chez les patients psychiatriques. Ensuite, les besoins de réinsertion générés par les deux grands conflits armés mondiaux vont révolutionner l'ergothérapie. Cette dernière permettait d'aborder les maladies dans une approche multifactorielle, multidisciplinaire et interdépendante déduite de la classification du fonctionnement, du handicap et de la santé promulguée par l'OMS (CIF- OMS) en

2001. Trois paradigmes du métier d'ergothérapie se sont succédés : traitement moral de Pinel donnant des bénéfices physiques et mentaux, le modèle biomédical 1950 - 1990 qui considère l'homme comme un ensemble de structures et de fonctions sur lesquelles il est possible d'agir isolément les unes des autres et le modèle bio-psycho-social en 1987 avec la notion d'écologie dès 1998 ; l'ergothérapeute doit alors appréhender le handicap de manière contextuelle et singulière (Hamonet, 2012).

2.4. Histoire de la rééducation- réadaptation au Bénin

Au Bénin, l'histoire de la MPR, se décline avec celle de la kinésithérapie en quatre périodes :

- de 1960 à 1990 qui a connu l'installation de structures de kinésithérapie;
- de 1990 à 2000 qui a connu la formation du premier médecin MPR et la création de l'Ecole Supérieure de Kinésithérapie (ESK);
- de 2000 à 2010 : sortie des premiers kinésithérapeutes de l'ESK;
- de 2010 à ce jour qui connaît : la création du DES de MPR en 2017 à la FSS de Cotonou, création Master à l'ESK et l'arrivée d'autres professionnels de la réadaptation (orthophoniste, orthoprothésiste, Podo-orthésiste),

3. Relations MPR, Kinésithérapie et Ergothérapie pour la prise en charge du handicap (Pinsault N, 2014; Monet, 2005 ; H. Hernandez, 2010 ; Bernard J, 2008 ; Gedda M, 2009)

Les objectifs d'autonomie et de réinsertion socio-professionnelle sont communs, centrés sur la personne en situation de handicap (ou handicapée). Ils sont basés sur une communication, une complémentarité et une coordination efficaces conduites par le médecin MPR en tenant compte des facteurs personnels et environnementaux. Chacun des spécialistes apporte une contribution dans :

- l'évaluation ou bilan pluridisciplinaire,
- l'élaboration du projet thérapeutique et du plan de soins personnalisé,
- les activités complémentaires coordonnées par le médecin MPR ,
- l'éducation du patient et de sa famille,
- la prévention et promotion de la santé,
- le suivi - évaluation et monitoring des actions,
- les interventions d'ergothérapie et de kinésithérapie sur prescription médicale.

Conclusion

La médecine physique et de réadaptation, la kinésithérapie et l'ergothérapie sont des domaines complémentaires qui concourent à la prévention, la prise en charge et surtout à la réduction du handicap. Leurs interventions s'inscrivent dans une synergie continue dont le chef d'orchestre reste le médecin rééducateur. Ce dernier assure la responsabilité médicale de l'équipe, le suivi régulier et surtout la coordination interdisciplinaire avec les autres spécialités médicales et chirurgicales. La MPR fédère plusieurs spécialités médicales et paramédicales au profit non pas de la maladie mais du malade.

Mots clés : Médecine Physique et Réadaptation, Kinésithérapie, Ergothérapie, Inter relations, Handicap

PREVENTION DES HEPATITES VIRALES ET DU CANCER DU FOIE



Aboudou Raïmi Kpossou

Clinique universitaire d'Hépatogastroentérologie, CNHU-HKM, Cotonou / FSS, UAC

Kpossou.raimi@yahoo.fr

Les hépatites virales B et C (HVB et HVC) sont de véritables problèmes de santé publique au Bénin, avec respectivement des prévalences de 6% et 1% environ en population générale. Ce sont des affections le plus souvent asymptomatiques pouvant passer à la chronicité. Elles peuvent alors aboutir à des complications graves mortelles telles que la cirrhose et le cancer du foie. Ce dernier est le 4^{ème} cancer le plus fréquent au Bénin, avec 622 nouveaux cas et 583 décès en 2022 d'après l'Organisation Mondiale de la Santé. Leurs voies de transmission sont pour l'hépatite B surtout périnatale et horizontale intrafamiliale mais aussi sexuelle et parentérale, et pour l'hépatite C essentiellement parentérale.

La prévention des hépatites repose sur le dépistage précoce des personnes atteintes et leur prise en charge (traitement, surveillance), la vaccination contre l'hépatite B (systématique à la naissance et des personnes dépistées séronégatives pour l'hépatite B), la sécurité des injections et des transfusions, l'éviction du partage d'objets pouvant entraîner une effraction cutanée (aiguilles, lames, ciseaux, coupe-ongles...) et des objets de toilette, les mesures visant la transmission sexuelle (bonne fidélité, usage de préservatifs). Les hépatites virales étant la principale cause de cancer du foie au Bénin, leur prévention et traitement permettent de prévenir ce cancer. Les autres mesures importantes sont l'éviction de consommation excessive d'alcool, la lutte contre le foie gras (activité physique régulière, alimentation peu grasse et peu sucrée, contrôle du poids) et la bonne conservation des céréales pour éviter le développement de champignons (*Aspergillus flavus* produisant des aflatoxines).

Mots clés : hépatites virales B et C, vaccination, dépistage, surveillance, cancer du foie.

AVANCEES, DEFIS ET PERSPECTIVES DANS LA LUTTE CONTRE LES MALADIES PRIORITAIRES AU BENIN : CAS DU PNT



Gildas AGODOKPESSI^{1,2}, Prudence WACHINOU^{1,2}, Mênouli ADJOBIMEY^{1,2}, Dissou AFFOLABI^{1,2}

1- Programme National Contre la Tuberculose (PNT), Ministère de la Santé, Bénin

2- Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey Calavi, Cotonou, Bénin

Depuis la fin de la pandémie de COVID-19, le nombre de cas de tuberculose toutes formes confondues dépistés augmente régulièrement et était de 4 351 en 2023. De plus, le taux de succès thérapeutique s'améliore d'année en année pour atteindre 91% pour la cohorte de 2022. Par ailleurs, le taux de décès reste stable autour de 5%. Ces résultats sont le fruit de diverses réformes opérées au niveau PNT depuis 2019. Elles concernent entre autres, la sensibilisation pour une appropriation de la lutte à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, la décentralisation de nombreuses activités du Programme, l'adoption de nouvelles stratégies de dépistage et de traitement, l'appui financier aux hôpitaux pour la prise en charge des cas compliqués et l'amélioration de la communication avec les différents acteurs de la lutte antituberculeuse.

De nombreux défis demeurent et concernent le dépistage tardif, l'insuffisance de financement pour améliorer le dépistage et l'instabilité du personnel chargé d'organiser la lutte au niveau décentralisé. Les perspectives sont de renforcer la prise en charge médicale des patients et de développer un modèle pérenne pour la prise en charge extra-médicale des patients.

Mots clés : tuberculose, avancées, défis, perspectives, programme national de lutte contre la tuberculose, Bénin.



AVANCEES, DEFIS ET PERSPECTIVES DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA AU BENIN

▪ Epidémiologie :

Le Spectrum (outils d'estimation des données VIH, ONUSIDA) pour l'année 2024 a projeté les estimations ci-dessous pour le Bénin :

- Population totale PVVIH : **67 161**
- Enfant 0-14 ans : **6 091**
- Nouvelles infections VIH : **1 359**
- Prévalence VIH : **0,8%** (15-49 ans, population générale)

Les études comportementales et biologiques réalisées au Bénin entre 2020 et 2022 ont estimé des prévalences au sein d'un certain nombre de populations sous surveillance dans notre pays qui sont dix à vingt fois supérieures à la prévalence moyenne nationale dans la population générale, classant ainsi notre pays dans la catégorie des pays à d'épidémie concentrée (**21,9% chez les TG ; 8,1% chez les HSH et 7,2% chez les TS**).

▪ Avancées dans la réponse nationale à l'infection par le VIH :

- Diminution importante des nouvelles infections au cours des dix dernières années passant de **4 390** en 2013 à **1 122** en 2023 ;
- Diminution de plus de **50%** des décès liés au Sida au cours des dix dernières années passant de **2 805** en 2013 à **1 597** en 2023 ;
- Objectif **3 X 95** établi à **86-96-91** au 31 décembre 2023 avec environ **60 000 PVVIH** sous ARV au 30 juin 2024 ;
- Couverture quasi-nationale en offre de services de PTME

(presque 100% des maternités du secteur public et 96% dans le privé) ;

- Mise à l'échelle de la double élimination de la transmission verticale VIH-Syphilis ;
- Démarrage de la triple élimination de la transmission VIH-Syphilis-Hépatite B ;
- Taux de dépistage du VIH et de mise sous ARV des femmes VIH+ supérieurs à 95% ;
- Taux de transmission mère-enfant du VIH estimé à 10% en 2023, meilleur taux en Afrique de l'Ouest et du Centre (ONUSIDA) ;
- Dispensation multi mois des ARV (MMD3-6) pour améliorer l'observance au traitement VIH ;
- Mise en œuvre de la PrEP comme stratégie complémentaire de prévention de l'infection à VIH ;
- Mise en œuvre de l'index testing ;
- Démédicalisation du test de dépistage du VIH avec utilisation des autotests ;

▪ Défis

- Connaissance du statut sérologique VIH chez les hommes (76% chez les hommes contre 97% chez les femmes) ;
- Connaissance du statut sérologique VIH chez les enfants (40% chez les enfants contre 85% pour l'ensemble des PVVIH au 31 décembre 2023) ;
- Réalisation du dépistage précoce chez les enfants exposés dans le délai de deux mois après la naissance (84% au 31 décembre 2023) ;

- Réalisation de la sérologie à 18 mois pour les enfants exposés au VIH (51% au 31 décembre 2023) ;

- Désagrégation de la file active par type de population (sous notification) par tranche d'âge et par sexe au niveau national (déjà une réalité sur certains sites) ;

▪ Perspectives

- Capitalisation des bonnes pratiques de PEPFAR : délai raccourci du rendu des résultats de charge virale, gestion individualisée des cas, E- tracker, e-Disp ;
- Renforcement de la réalisation de la charge virale chez les femmes enceintes séropositives au VIH au 3^{ème} trimestre de grossesse et femmes allaitantes ;
- Mise à l'échelle de la triple élimination de la TME verticale VIH-Syphilis-Hépatite B ;
- Développement du plan opérationnel issu de l'analyse situationnel de la PEC pédiatrique (plan rédigé et mobilisation de ressources en cours) ;
- Mise en place de la dispensation communautaire des ARV à travers 12 points de distribution communautaire des ARV ;
- Mise en place d'un climat juridique favorable à travers la révision de la loi VIH 2005 (document déjà rédigé, reste la procédure parlementaire).



AVANCEES, DEFIS ET PERSPECTIVES DANS LA LUTTE CONTRE LES HEPATITES VIRALES B ET C AU BENIN

EPIDEMIOLOGIE

Des différentes données factuelles ou estimations, la prévalence de l'hépatite B est de 9,9 % et celle de l'hépatite C est de 1,3% dans la population générale. Le Bénin est classé dans la zone rouge de l'endémicité ;

La prévalence de l'hépatite B chez les femmes enceintes est de 6,58% (2023) contre 7,09% (2021). Au niveau des agents de santé en 2022, la prévalence du l'hépatite B était 7,9% et de 1% (hépatite C).

Avancées

- ✓ Loi n°2017-28 du 1er décembre 2017 portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C en République du Bénin
- ✓ Plan National de Développement Sanitaire 2018-2022 (Hépatite maladie prioritaire à l'instar du VIH/Sida, Paludisme et Tuberculose)
- ✓ Création du Programme National de Lutte contre les Hépatites par arrêté du Ministre le 20 juillet 2018 et mise en place de la coordination en septembre 2018 avec mission de coordonner la mise en œuvre des politiques et stratégies de lutte contre les hépatites à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et sur toute l'étendue du territoire
- ✓ Introduction du vaccin anti hépatite B, dose de naissance en octobre 2020 sur le Budget national faisant du Bénin le 11 pays africain à mettre en œuvre cette stratégie
- ✓ Dépistage des hépatites B et C chez 15310 agents sur 20892 pour le secteur public du Bénin soit 73,28% en 2022 (Prise en charge des cas et/ou vaccination)
- ✓ Décentralisation de la prise en charge déléguée aux médecins généralistes formés
- ✓ Traitement de l'hépatite C gratuit y compris la réalisation de la charge virale pré et post thérapeutique depuis 2019 sur budget national
- ✓ Indicateurs des hépatites virales B et C intégrés dans le DHIS2 en 2021

Défis

- Production et remontée des données de qualité sur les hépatites B et C
- Disponibilité des intrants tels que tests rapides et réactifs de charge virale et médicaments
- Accroissement des ressources

Perspectives

- Plaidoyer pour la mobilisation de ressources



ACTIVITES DE LA MEDECINE HOSPITALIERE FACE AUX FLEAUX SANITAIRES AU BENIN

ZANNOU Djimon Marcel,

Professeur de médecine interne, Président du Conseil national de la médecine hospitalière

La médecine hospitalière au Bénin joue un rôle crucial dans la lutte contre les fléaux sanitaires qui affectent le pays. Face à la diversité des défis sanitaires, les établissements hospitaliers béninois ont mis en place une panoplie d'actions pour prévenir, diagnostiquer et traiter ces maladies. Avant de détailler les activités hospitalières, il convient de mentionner quelques-uns des principaux fléaux sanitaires qui touchent le Bénin. Il s'agit des Maladies infectieuses (Paludisme, tuberculose, VIH/SIDA, méningite, fièvres hémorragiques), des maladies non transmissibles (Hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, cancers), des maladies liées à la malnutrition (sous-nutrition chez les enfants, carences en micronutriments) et des maladies tropicales négligées (Onchocercose, filariose lymphatique, schistosomiase).

Les activités de la médecine hospitalière face à ces défis concernent i) la prise en charge des patients : les médecins hospitaliers assurent des consultations pour dépister et diagnostiquer les maladies, ils administrent les traitements appropriés, qu'il s'agisse de médicaments, de thérapies ou d'interventions chirurgicales, puis un suivi régulier des patients permet d'évaluer l'efficacité des traitements et d'adapter les soins si nécessaire ; ii) la prévention à travers la vaccination, l'éducation sanitaire sur les mesures de prévention (hygiène, alimentation équilibrée, etc.), la promotion de la santé ; iii) les soins de réadaptation et les soins palliatifs ; iv) la surveillance épidémiologique avec la collecte de données sur les maladies (ce qui permet de suivre leur évolution et d'identifier les zones à risque) puis la déclaration des cas à l'autorité sanitaire compétente lorsque c'est nécessaire ; v) la recherche pour mieux comprendre les facteurs de risque des maladies ; vi) la collaboration avec les autres acteurs de la santé pour renforcer le système de santé et participer à des réseaux de surveillance et de réponse aux épidémies.

Malgré les efforts déployés, la médecine hospitalière au Bénin est confrontée à plusieurs autres défis : l'insuffisance de ressources humaines qualifiées, de médicaments et d'équipements, le retard aux soins pour des raisons d'accessibilité et l'émergence de nouvelles maladies comme le COVID-19 qui mettent à rude épreuve les systèmes de santé.

Pour améliorer la situation, il est nécessaire de renforcer les systèmes de santé, d'investir davantage dans les ressources humaines et matérielles, et de promouvoir une approche intégrée de la santé.

MA SANTE MENTALE, J'EN PRENDS SOIN

ANAGONOU L¹

^{1.} *Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, UFR de médecine, Département de santé mentale, Cotonou, Bénin*

Auteur correspondant : ANAGONOU Lucrèce

Tél : +229 66263585 Courriel : luccea2@gmail.com



La santé mentale fait partie intégrante de la santé globale. Elle est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. La bonne santé mentale impacte, non seulement le bien-être de l'individu mais également le bon fonctionnement de la communauté.

Les pratiques qui favorisent la bonne santé mentale allient l'adoption de saines habitudes de vie, la culture de relations saines et positives, et le développement d'habiletés de gestion de stress et de résolution de problèmes. Elles permettent d'être performant, et favorisent la consolidation de la résilience nécessaire pour faire face aux adversités inhérentes à la vie.

Tout comme la santé physique, la santé mentale est aussi importante pour le bien-être. Chaque individu, quel que soit son statut et ses différents milieux de vie, a le pouvoir d'agir pour en prendre soin. La communauté a le devoir d'y œuvrer.

Mots-clés : santé mentale, bien-être, résilience, individu, communauté.

HYGIENE MENSTRUELLE : PARLONS-EN

Conférencière grand public : Dr TSHABU AGUEMON Christiane, professeur titulaire de gynécologie-obstétrique à la Faculté des Sciences de la Santé



Dans cette conférence interactive, nous aborderons l'importance de l'hygiène menstruelle, un sujet souvent tabou mais essentiel pour la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles. A travers des explications claires et accessibles, nous expliquerons le cycle menstruel, les différents produits d'hygiène disponibles, ainsi que les bonnes pratiques à adopter pour garantir une hygiène optimale. Nous mettrons également un accent sur les enjeux socioculturels et environnementaux liés à l'hygiène menstruelle, notamment l'accès aux produits menstruels et les impacts des déchets générés. Des études de cas seront partagés pour illustrer les défis rencontrés par de nombreuses femmes à travers le monde. Enfin, cette conférence sera l'occasion d'ouvrir le dialogue sur les menstruations, de briser le plafond de verre et de promouvoir une éducation inclusive et respectueuse. Les participants seront encouragés à poser des questions afin de favoriser une meilleure compréhension. Rejoignez-nous pour cette discussion enrichissante et engageante sur un sujet qui nous concerne tous !



ACTIVITES DE LA MEDECINE HOSPITALIERE FACE AUX FLEAUX SANITAIRES AU BENIN

ZANNOU Djimon Marcel,

Professeur de médecine interne, Président du Conseil national de la médecine hospitalière

La médecine hospitalière au Bénin joue un rôle crucial dans la lutte contre les fléaux sanitaires qui affectent le pays. Face à la diversité des défis sanitaires, les établissements hospitaliers béninois ont mis en place une panoplie d'actions pour prévenir, diagnostiquer et traiter ces maladies. Avant de détailler les activités hospitalières, il convient de mentionner quelques-uns des principaux fléaux sanitaires qui touchent le Bénin. Il s'agit des Maladies infectieuses (Paludisme, tuberculose, VIH/SIDA, méningite, fièvres hémorragiques), des maladies non transmissibles (Hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, cancers), des maladies liées à la malnutrition (sous-nutrition chez les enfants, carences en micronutriments) et des maladies tropicales négligées (Onchocercose, filariose lymphatique, schistosomiase).

Les activités de la médecine hospitalière face à ces défis concernent i) la prise en charge des patients : les médecins hospitaliers assurent des consultations pour dépister et diagnostiquer les maladies, ils administrent les traitements appropriés, qu'il s'agisse de médicaments, de thérapies ou d'interventions chirurgicales, puis un suivi régulier des patients permet d'évaluer l'efficacité des traitements et d'adapter les soins si nécessaire ; ii) la prévention à travers la vaccination, l'éducation sanitaire sur les mesures de prévention (hygiène, alimentation équilibrée, etc.), la promotion de la santé ; iii) les soins de réadaptation et les soins palliatifs ; iv) la surveillance épidémiologique avec la collecte de données sur les maladies (ce qui permet de suivre leur évolution et d'identifier les zones à risque) puis la déclaration des cas à l'autorité sanitaire compétente lorsque c'est nécessaire ; v) la recherche pour mieux comprendre les facteurs de risque des maladies ; vi) la collaboration avec les autres acteurs de la santé pour renforcer le système de santé et participer à des réseaux de surveillance et de réponse aux épidémies.

Malgré les efforts déployés, la médecine hospitalière au Bénin est confrontée à plusieurs autres défis : l'insuffisance de ressources humaines qualifiées, de médicaments et d'équipements, le retard aux soins pour des raisons d'accessibilité et l'émergence de nouvelles maladies comme le COVID-19 qui mettent à rude épreuve les systèmes de santé.

Pour améliorer la situation, il est nécessaire de renforcer les systèmes de santé, d'investir davantage dans les ressources humaines et matérielles, et de promouvoir une approche intégrée de la santé.

**MERCI A
NOS PARTENAIRES**

Pour votre soutien et votre bienveillance recevez nos remerciements :

- Ministère de la Santé
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
- Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance
- ENABEL
- Ambassade de France
- Anciens étudiants en médecine de la FSS notamment la 24ème, la 26ème la 37^{ème} et les autres promotions associatives
- Promoteur des jus naturels Livek
- Promoteur de la boisson Sinunu
- Agence Phenix PARTNERS
- Agence GH
- Directeur général de l'Agence Nationale de Protection Sociale
- Directeur général de l'ABEGIEF
- Responsable de la PHARMACIE EKPE,
- Responsable de la PHARMACIE SAINTE FAMILLE
- Au responsable de la PHARMACIE SACRE COEUR

